

Monograf
**MENEMBUS BATAS PENOLAKAN
MENINGKATKAN PENERIMAAN
TPT PADA KONTAK SERUMAH**

Nur Fadhilah
Iwan Tri Bowo
Keysha Yasmine Asshafira



Buku Monograf
MENEMBUS BATAS PENOLAKAN:
MENINGKATKAN PENERIMAAN
TPT PADA KONTAK SERUMAH

Nur Fadhilah
Iwan Tri Bowo
Keysha Yasmine Asshafira



Buku Monograf
MENEMBUS BATAS PENOLAKAN:
MENINGKATKAN PENERIMAAN TPT
PADA KONTAK SERUMAH

Nur Fadhilah
Iwan Tri Bowo
Keysha Yasmine Asshafira

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Achmad Faisal

ISBN: 978-623-89965-6-8
Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram @bimbel.optimal
Tiktok @maskokooo
www.optimaluntuknegeri.com
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



Prakata

Alhamdulillahirobbilalaamin,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan buku monograf yang berjudul *"Menembus Batas Penolakan: Meningkatkan Penerimaan TPT pada Kontak Serumah"* dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai wujud kepedulian penulis terhadap upaya pengendalian tuberkulosis (TBC) di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan penerimaan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) pada kelompok yang paling rentan, yaitu kontak serumah.

TBC bukan hanya persoalan medis, ia adalah cermin ketimpangan sosial, potret gagalnya sistem komunikasi kesehatan, dan tanda bahwa stigma masih lebih kuat daripada upaya penyembuhan. Dalam bayang-bayang penyakit yang telah lama menjadi epidemi global ini, tersembunyi satu lapisan penting namun kerap terabaikan "kelompok kontak serumah". Mereka adalah benteng pertahanan pertama sekaligus yang paling rentan dalam rantai penularan TBC. Namun ironisnya, merekalah yang sering kali menolak terapi pencegahan.

Buku monograf ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus panggilan nurani. Dengan mengusung judul *"Menembus Batas Penolakan: Meningkatkan Penerimaan TPT pada Kontak Serumah"*, penulis mengajak pembaca untuk tidak lagi bersembunyi di balik data dan kebijakan yang normatif. Saatnya berbicara lebih lantang: mengapa mereka menolak? Apa yang salah dalam pendekatan kita selama ini? Dan bagaimana strategi intervensi dapat digeser dari sekadar program menjadi gerakan yang mengakar?

Melalui sintesis antara data empiris, teori-teori perilaku kesehatan, dan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas, buku ini mencoba memecah kebuntuan yang selama ini membelenggu pelaksanaan TPT. Penulis menggugat asumsi lama, membongkar mitos yang menyelimuti TPT, dan menantang pembaca untuk berpikir ulang tentang strategi advokasi yang benar-benar berdampak.

Karya ini tidak hanya dimaksudkan sebagai referensi akademik, melainkan juga sebagai katalis perubahan. Kepada tenaga kesehatan, akademisi, pembuat kebijakan, serta para pegiat kesehatan Masyarakat, buku ini adalah ajakan untuk bertindak, untuk mendobrak kebisuan, untuk tidak lagi membiarkan penolakan berlangsung tanpa perlawanan yang terencana dan berbasis ilmu.

Akhir kata, penulis menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyusunan buku ini, baik melalui data, refleksi kritis, maupun energi perjuangan di lapangan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga buku ini menjadi bagian dari langkah kolektif menuju eliminasi TBC yang bukan hanya terukur, tetapi juga bermakna secara sosial dan kemanusiaan.

Selamat membaca.

Mei 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	vi

BAB 1 Pendahuluan.....	1
-------------------------------	----------

BAB 2 Tuberkulosis (TBC).....	4
--------------------------------------	----------

A. Pengertian Tuberkulosis.....	4
B. Penularan Tuberkulosis	6
C. Tanda dan Gejala Tuberkulosis.....	8
D. Pengobatan Tuberkulosis	9
E. Masalah yang Lazim Terjadi Selama Program Pengobatan Tuberkulosis	13

BAB 3 Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB)	15
--	-----------

A. Definisi ILTB.....	15
B. Faktor Risiko ILTB & Kelompok Rentan.....	16
C. Fenomena ILTB di Dunia & Indonesia	17
D. Terapi Pencegahan TBC (TPT) Sebagai Bagian dari Pelayanan Tuberkulosis	19
E. Algoritma Pemberian TPT (Mengacu pada WHO & Kemenkes RI)	21
F. Tantangan dan Peluang dalam Memperluas Jangkauan TPT	23

BAB 4 Pendekatan Health Belief Model dalam

Memprediksi Penerimaan Terapi Pencegahan

Tuberkulosis (TPT)	27
---------------------------------	-----------

A. Pendahuluan.....	27
B. <i>Perceived Susceptibility</i> dalam Memprediksi Penerimaan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT).....	29

C. <i>Perceived Severity</i> dalam Memprediksi Penerimaan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT).....	34
D. <i>Perceived Benefits</i> (Manfaat yang Dirasakan).....	39
E. <i>Perceived Barriers</i> (Hambatan yang Dirasakan)	44
F. <i>Cues to Action</i> (Isyarat untuk Bertindak)	51
BAB 5 Penutup	56
Daftar Pustaka	59
Glosarium	65
Profil Penulis	67



BAB 1

Pendahuluan

Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular kronis yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini tetap menjadi masalah kesehatan global yang serius karena tingkat penularannya yang tinggi serta kemampuannya untuk menyerang berbagai organ tubuh, terutama paru-paru. Menurut *Global Tuberculosis Report 2023* yang dirilis oleh World Health Organization (WHO), TBC menjadi penyebab kematian tertinggi kedua secara global setelah COVID-19 pada tahun 2022, dengan estimasi 10,6 juta kasus baru dan 1,3 juta kematian akibat TBC, belum termasuk 167.000 kematian tambahan dari penderita TBC dengan HIV. Tanpa pengobatan yang tepat, sekitar 50% pasien TBC akan meninggal dunia, menandai keganasan penyakit ini dalam konteks kesehatan masyarakat global.

Sekitar 5-10% orang dengan Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTb) akan berkembang menjadi TBC aktif dalam 5 tahun sejak pertama kali terinfeksi (Kemenkes RI, 2018). WHO memperkirakan dari dua miliar orang dengan ILTB, 10% diantaranya (200 juta) akan berkembang menjadi TBC.

Review sistematis yang dilakukan terhadap 11 penelitian di Asia Tenggara menunjukkan 24,4% - 69,2% anak umur di bawah 15 tahun berkontak dengan orang TBC aktif dan 3,3% - 5,5% diantaranya akan berkembang menjadi TBC aktif (Kemenkes RI, 2016). Orang yang kontak erat dengan penderita TBC (tinggal dalam satu rumah) adalah kelompok yang paling rentan, apalagi jika sistem kekebalan tubuh yang lemah.

Model epidemiologis yang dikembangkan oleh Dye et al. (2013) menunjukkan bahwa target ambisius *End TB Strategy 2035*, yaitu pengurangan insiden TBC sebesar 90% dan kematian akibat TBC sebesar 95%, hanya dapat dicapai dengan pendekatan ganda: pengobatan kasus TBC aktif secara efektif serta pencegahan melalui pemberian TPT pada individu dengan ILTB. Strategi ini kemudian diperkuat oleh pendekatan layanan TBC terintegrasi, di mana seluruh anggota keluarga serumah dari pasien TBC dianggap sebagai satu kesatuan penerima layanan, baik terapi maupun pencegahan (The Aurum Institute, 2019).

Meskipun TPT telah diakui secara global sebagai intervensi krusial, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cakupan pemberian TPT untuk kontak serumah pada tahun 2022 masih sangat rendah, yaitu kurang dari 0,5%. Walaupun meningkat menjadi 2,6% (setara dengan 35.006 orang) pada tahun 2023, angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 68%.

Penelitian implementasi program TPT sejak tahun 2012 hingga 2018 di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi cenderung berulang, antara lain: rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya TPT, keterbatasan kapasitas tenaga kesehatan dalam menegakkan diagnosis ILTB dan memberikan TPT, serta belum memadainya sarana diagnostik seperti *tuberculin skin test* (TST) dan *interferon-gamma release assays* (IGRA) di fasilitas layanan primer. Selain itu, kendala logistik dan regulasi internal juga memperlambat alur rujukan dan pelaksanaan terapi.

Mengingat tingginya beban penyakit TBC dan tantangan dalam pengendaliannya, khususnya melalui strategi pencegahan seperti TPT, diperlukan upaya sistematis dan berbasis bukti dalam mengoptimalkan program ini, mulai dari peningkatan edukasi masyarakat, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga perbaikan sistem pelayanan dan dukungan kebijakan. Monograf ini disusun sebagai kontribusi ilmiah dalam menggambarkan secara lebih komprehensif dinamika implementasi TPT, khususnya di wilayah dengan beban kasus tinggi, serta untuk menyediakan dasar bagi advokasi kebijakan dan pengembangan program di masa mendatang.

BAB 2

Tuberkulosis (TBC)

A. Pengertian Tuberkulosis

Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* (MTb), ditemukan tahun 1882 oleh ilmuwan Jerman, yaitu Dr. Robert Koch. Penyakit ini dapat menyerang berbagai bagian tubuh, namun paling umum menyerang paru-paru, yang dikenal sebagai TBC Paru tetapi juga dapat menyebar ke bagian lain tubuh (Pitaloka & Siyam, 2020).

Kuman MTb berbentuk batang memiliki sifat unik, yaitu tahan terhadap pewarnaan asam. Oleh karena itu, dikenal sebagai Basil Tahan Asam (BTA). MTb cepat mati jika terkena sinar matahari langsung, tetapi dapat bertahan beberapa jam di tempat gelap dan lembab. Infeksi kronik yang disebabkan oleh MTb biasanya menyerang paru-paru. Droplet nucleus dapat menyebarkan bakteri melalui udara. Droplet ini terbentuk ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi (Gultom & Isaura, 2024)

TBC adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh *MTb*, sejenis kuman berbentuk batang dengan ukuran panjang 1-4/Um dan tebal 0,3-0,6/Um, sebagian besar kuman *MTb* terdiri dari asam lemak (lipid), lipid inilah yang membuat kuman lebih tahan terhadap asam dan lebih tahan terhadap gangguan kimia dan fisik (Okuonghae, 2013). Kuman ini dapat tahan hidup pada udara kering maupun dingin (dapat tahan bertahun-tahun dalam lemari es), hal ini terjadi karena kuman berada dalam sifat *dormant* yaitu dapat bangkit kembali dan menjadikan TBC aktif lagi. Sifat dari kuman ini adalah anaerob, sifat ini menunjukkan bahwa kuman lebih menyukai jaringan yang tinggi kandungan oksigennya, dalam hal ini tekanan oksigen bagian apikal paru-paru lebih tinggi dari pada bagian lain, sehingga bagian apikal ini merupakan tempat predileksi penyakit TBC (Bađćý, Bray, Caban, Yao, & Mollura, 2012; Shen et al., 2010).

TBC tergolong airborne disease yakni penularan melalui *droplet nuclei* yang dikeluarkan ke udara oleh individu terinfeksi dalam fase aktif (Munaj, Khaidir, 2010). Selain itu kuman TBC dapat keluar bebas di udara saat penderita TBC batuk, bersin, bernyayi, dan bersiul. Penularan terjadi karena kuman dibatukkan atau dibersinkan keluar menjadi *droplet nuclei* dalam udara. Partikel infeksi ini dapat menetap dalam udara bebas selama 1 – 2 jam (KemenkesRI, 2016).

B. Penularan Tuberkulosis

Cara penularan TBC Paru dimulai saat sumber penularan yaitu pasien TBC BTA positif batuk, pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak (*droplet nuclei*). Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak, umumnya penularan terjadi dalam ruangan dimana percikan dahak berada dalam waktu yang lama dan percikan dapat bertahan selama beberapa jam dalam keadaan gelap dan lembab (Kemenkes RI, 2016). Kuman-kuman yang melayang di udara atau kuman yang tertinggal pada barang-barang sekitar penderita dapat terhisap oleh anggota keluarga, hal inilah yang dapat menyebabkan penularan penyakit TBC terutama pada anggota keluarga yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah dan lebih rentan terhadap penyakit menular.

Daya penularan seorang pasien ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Semakin tinggi derajat kepositifan hasil pemeriksaan dahak, semakin menular pasien tersebut (Kemenkes RI, 2016). Faktor yang memungkinkan seseorang terpajan bakteri MTb ditentukan oleh konsentrasi percikan dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut. Masa inkubasinya selama 3-6 bulan (Widoyono, 2005). Masuknya bakteri MTb tidak serta merta dapat menimbulkan sakit, secara alamiah bakteri MTb akan melewati beberapa tahapan sampai dengan munculnya gejala/sakit.

Tahap Peka/ Rentan/ Pre pathogenesis; Pada tahap ini telah terjadi interaksi antara pejamu dengan bibit penyakit. Tetapi interaksi ini masih diluar tubuh manusia, dalam arti bibit penyakit berada di luar tubuh manusia dan belum masuk kedalam tubuh pejamu. Pada keadaan ini belum ditemukan adanya tanda-tanda penyakit dan daya tahan tubuh pejamu masih kuat dan dapat menolak penyakit. Keadaan ini disebut sehat.

Tahap Pra gejala/Masa Inkubasi/ Sub-Klinis; Pada tahap ini telah terjadi infeksi, tetapi belum menunjukkan gejala dan masih belum terjadi gangguan fungsi organ. Waktu yang diperlukan sejak masuknya kuman TBC hingga terbentuknya kompleks primer secara lengkap disebut sebagai masa inkubasi TBC. Masa inkubasi TBC berlangsung dalam waktu 4-8 minggu dengan rentang waktu antara 2-12 minggu. Dalam masa inkubasi tersebut, kuman tumbuh hingga mencapai jumlah 10³-10⁴, yaitu jumlah yang cukup untuk merangsang respons imunitas seluler.

Tahap Klinis (*stage of clinical disease*); merupakan kondisi ketika telah terjadi perubahan fungsi organ yang terkena dan menimbulkan gejala. Gejala penyakit TBC dapat dibagi menjadi gejala umum dan gejala khusus yang timbul sesuai dengan organ yang terlibat. Gambaran secara klinis tidak terlalu khas terutama pada kasus baru, sehingga cukup sulit untuk menegakkan diagnosa secara klinik.

Probabilitas bahwa seseorang dengan TBC akan menularkan MTb kepada orang lain ditentukan oleh banyak faktor (Mathema dkk, 2017). Pertama, individu dengan TBC yang lebih parah dapat mengeluarkan jumlah droplet nuklei yang lebih tinggi dengan menghasilkan droplet pada tingkat yang lebih tinggi. Tingkat produksi droplet dapat dipengaruhi oleh frekuensi dan kekuatan batuk dan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan patologi yang memungkinkan patogen untuk melarikan diri ke jalan napas misalnya rongga (Kaplan G dkk, 2003).

Sebuah temuan terbaru menunjukkan bahwa ukuran produksi aerosol batuk dapat mengidentifikasi individu yang lebih mungkin berkontribusi terhadap penularan di komunitas (Jones-Lopez, 2013, 2016). Jarak yang lebih dekat dan durasi kontak yang lebih lama antara kasus sumber infeksi dan individu yang rentan meningkatkan risiko penularan. Keterlambatan dalam diagnosis TBC atau memulai pengobatan yang memadai meningkatkan prevalensi TBC menular, sehingga meningkatkan kemungkinan penularan selanjutnya (Cheng, 2013).

C. Tanda dan Gejala Tuberkulosis

Seseorang yang sudah terinfeksi dengan bakteri MTb, biasanya menimbulkan beberapa macam gejala (Nasution et al., 2023), yaitu:

1. Batuk berkepanjangan yang berlangsung lebih dari tiga minggu. Batuk ini dapat bersifat kering atau disertai dahak dan terkadang bercampur dengan darah

2. Demam yang berlangsung lama dan suhu tubuh cenderung meningkat di sore atau malam hari dan bisa disertai dengan menggigil.
3. Mengalami Penurunan Berat Badan disebabkan oleh berkurangnya nafsu makan atau gangguan metabolisme akibat infeksi.
4. Berkeringat berlebihan pada malam hari meskipun tanpa aktifitas fisik yang signifikan dan dapat mengganggu tidur.
5. Penderita sering merasa lemah dan kehilangan energi yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari.

Selain gejala umum yang biasanya muncul pada pasien TBC diidentifikasi dalam beberapa gejala khusus, yaitu (Rimbi, 2014):

1. Suara napas yang lemah disertai sesak napas.
2. Nyeri dada.

D. Pengobatan Tuberkulosis

Tujuan pengobatan TBC adalah; menyembuhkan pasien dan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup, mencegah kematian akibat TBC atau dampak buruk yang ditimbulkannya, mencegah kekambuhan TBC, mengurangi risiko penularan TBC, serta mencegah terjadinya dan penularan TBC yang resisten terhadap obat (Kemenkes RI, 2016). Obat Anti Tuberkulosis (OAT) merupakan komponen terpenting dalam pengobatan TBC.

Pengobatan TBC merupakan salah satu upaya yang paling efisien untuk mencegah penyebaran kuman TBC lebih lanjut, oleh karena itu pengobatan yang adekuat harus memenuhi prinsip-prinsip: diberikan dalam bentuk kombinasi OAT yang tepat yang mengandung paling sedikit 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi, diberikan dengan dosis yang tepat, ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh Pengawas Menelan Obat (PMO) hingga selesai pengobatan, dan pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup, dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjutan, sebagai pengobatan yang adekuat untuk mencegah terjadinya kekambuhan (Kemenkes RI, 2016).

Pengobatan tahap awal (fase intensif) diberikan setiap hari, tujuannya adalah untuk secara efektif mengurangi jumlah kuman di dalam tubuh pasien dan meminimalkan pengaruh sejumlah kecil kuman yang mungkin sudah kebal sejak sebelum pasien menerima pengobatan. Pengobatan awal pada semua pasien baru, harus diberikan selama 2-3 bulan. Pada umumnya, dengan pengobatan yang teratur dan tanpa komplikasi, tingkat penularan sudah sangat menurun setelah 2 minggu pertama pengobatan. Sedangkan pengobatan tahap lanjutan (4-7 bulan) bertujuan untuk membunuh sisa kuman yang masih ada di dalam tubuh, terutama bakteri yang persisten sehingga penderita dapat sembuh dan mencegah kekambuhan (Kemenkes RI, 2016).

Berbagai jenis OAT yang harus dikonsumsi oleh pasien TBC memberikan berbagai efek samping. Efek samping tersebut terkadang menjadi sumber masalah baru baik bagi pasien maupun program pengendalian TBC, tidak sedikit pasien yang menolak pengobatan karena efek samping, bahkan banyak ditemukan pasien yang menyatakan berhenti minum obat dengan alasan sudah merasa sehat atau tidak ada keluhan lagi. Oleh karena itu, pengendalian TBC di Indonesia menggunakan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang telah direkomendasikan oleh WHO sejak tahun 1995. DOTS merupakan strategi pengendalian TBC yang bertujuan untuk memutus penularan penyakit TBC sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian TBC di Masyarakat (Kemenkes RI, 2016).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penting untuk memastikan bahwa pasien benar benar menelan semua obat yang diberikan sesuai petunjuk, dengan pengawasan langsung oleh PMO yang bertujuan untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Pemilihan tempat perawatan harus disepakati dengan pasien untuk memberikan kenyamanan, artinya pasien dapat memilih untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat dengan rumah pasien atau PMO yang datang berkunjung ke rumah pasien. Jika tidak ada faktor yang menyulitkan, pengobatan dapat diberikan secara rawat jalan (Kemenkes RI, 2016).

Menelan OAT secara lengkap dan teratur hingga sembuh dapat mencegah penularan TBC yang lebih luas ke lingkungan, sehingga diharapkan seluruh pasien yang telah terdiagnosa TBC harus patuh dalam menjalankan program pengobatan sampai selesai dan dinyatakan sembuh. Kepatuhan dalam menjalankan pengobatan diduga kuat sebagai faktor yang dapat mengurangi risiko penularan infeksi TB Paru (Tola, 2014). Intervensi konseling psikologis dan edukasi yang dipandu oleh HBM secara signifikan menurunkan tingkat ketidakpatuhan pengobatan pada kelompok intervensi.

Oleh karena itu kepada petugas kesehatan disarankan memberikan konseling psikologis dan pendidikan kesehatan kepada pasien TBC yang sedang menjalani pengobatan rutin. Hal ini dapat dicapai jika intervensi ini dipandu oleh teori perilaku dan dimasukkan ke dalam strategi pengobatan TBC yang berkesinambungan. Model intervensi Health Belief Model (HBM) menggambarkan tentang persepsi seseorang terhadap seberapa pentingkah upaya pencegahan penyakit. Intervensi dalam bentuk konseling psikologis dan edukasi menjadi pilihan tepat untuk mengatasi masalah responden.

Sebuah tinjauan literatur berjudul "Pengobatan yang tepat untuk TBC yang resisten, menuliskan sebuah kesimpulan yang mendalam, bahwa hal yang paling penting dalam mengendalikan program TBC adalah: Mengobati pasien yang tepat, pada waktu yang tepat,

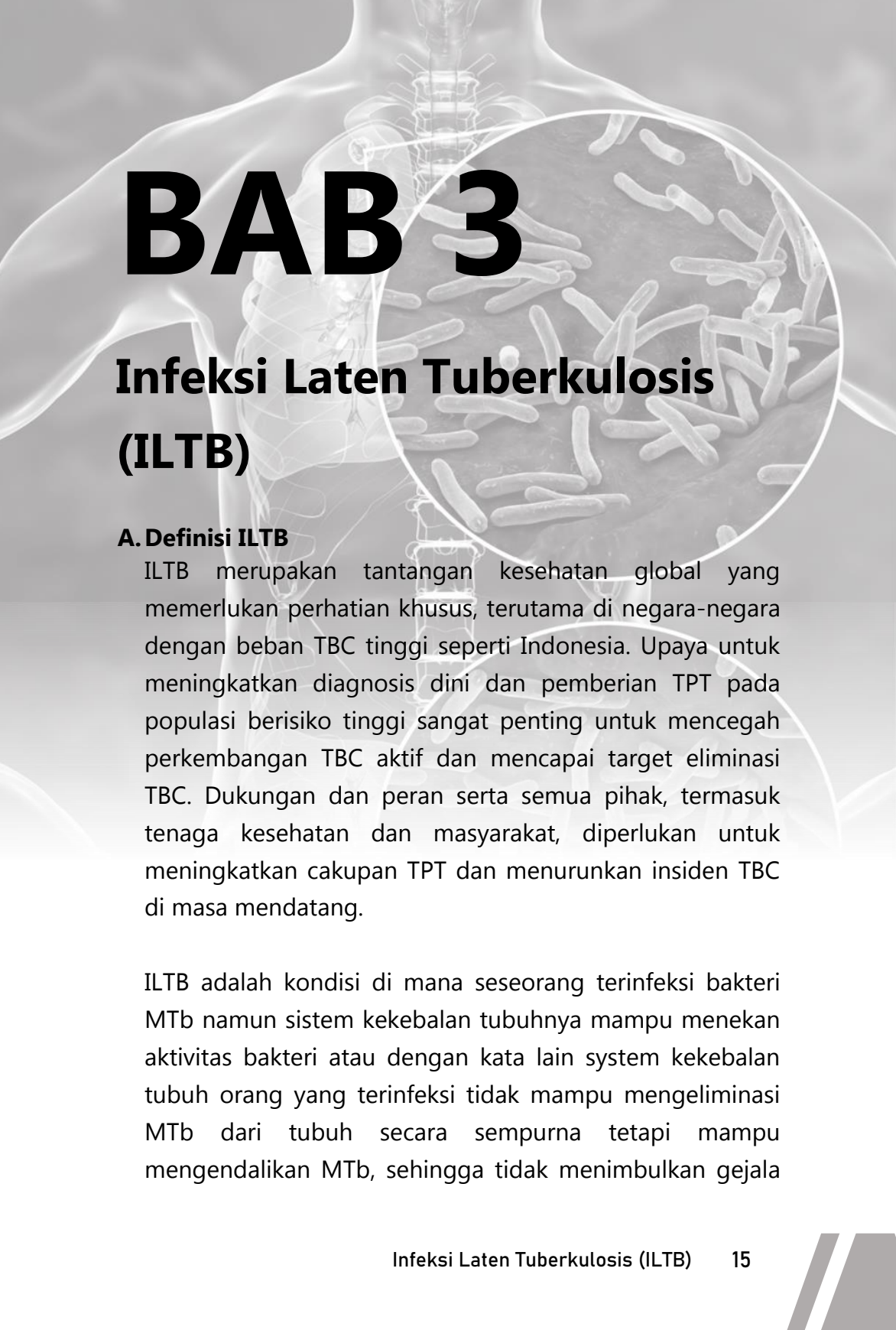
dengan obat yang tepat (Mahomed S; Padayatchi N; Singh J, Naidoo KL, 2019).

E. Masalah yang Lazim Terjadi Selama Program Pengobatan Tuberkulosis

Masalah dalam ketercapaian program pengobatan TBC seringkali terjadi akibat berbagai faktor yang bersifat multidimensi. Masalah yang lazim ditemukan sehubungan dengan program pengobatan pasien TBC diantaranya adalah; 1) Ketidakpatuhan Pasien terhadap pengobatan (Kemenkes RI, 2023), beberapa faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan meliputi: durasi pengobatan yang panjang (6-9 bulan) menyebabkan pasien sering menghentikan terapi setelah merasa sehat, kurangnya pengetahuan pasien tentang pentingnya pengobatan yang tuntas, penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan tingkat pemahaman rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk menghentikan pengobatan), efek samping obat seperti mual, muntah, dan reaksi alergi yang memicu ketidaknyamanan. 2) Resistensi Obat; penghentian pengobatan sebelum waktunya dapat menyebabkan resistensi obat, yaitu Multi-Drug-Resistant Tuberculosis (MDR-TB) (Kemenkes RI, 2023). Resistensi ini membuat pengobatan menjadi lebih kompleks dan mahal. 3) Faktor Sosial dan Ekonomi; kemiskinan dan akses layanan kesehatan, banyak pasien, terutama di daerah terpencil, mengalami kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan akibat biaya transportasi atau waktu yang terbatas, stigma sosial terhadap penderita TBC sering kali membuat pasien

enggan mencari pengobatan. Selanjutnya 4) masalah keterbatasan system kesehatan; kurangnya dukungan program pengawasan menelan obat (PMO), dalam beberapa kasus, pasien tidak mendapatkan pendampingan yang memadai untuk memastikan mereka mengonsumsi obat secara rutin.

Selain masalah-masalah tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang juga sering menjadi hambatan dalam ketercapaian program pengobatan TBC, yaitu ILTB. LTB termasuk salah satu tantangan besar dalam pengendalian TBC. ILTB adalah suatu kondisi di mana seseorang terinfeksi bakteri *MTb* tetapi tidak menunjukkan gejala klinis dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain karena bakteri tersebut berada dalam keadaan “tidur” atau tidak aktif di dalam tubuh.



BAB 3

Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB)

A. Definisi ILTB

ILTB merupakan tantangan kesehatan global yang memerlukan perhatian khusus, terutama di negara-negara dengan beban TBC tinggi seperti Indonesia. Upaya untuk meningkatkan diagnosis dini dan pemberian TPT pada populasi berisiko tinggi sangat penting untuk mencegah perkembangan TBC aktif dan mencapai target eliminasi TBC. Dukungan dan peran serta semua pihak, termasuk tenaga kesehatan dan masyarakat, diperlukan untuk meningkatkan cakupan TPT dan menurunkan insiden TBC di masa mendatang.

ILTB adalah kondisi di mana seseorang terinfeksi bakteri MTb namun sistem kekebalan tubuhnya mampu menekan aktivitas bakteri atau dengan kata lain system kekebalan tubuh orang yang terinfeksi tidak mampu mengeliminasi MTb dari tubuh secara sempurna tetapi mampu mengendalikan MTb, sehingga tidak menimbulkan gejala

klinis tuberkulosis (TBC). Meskipun tanpa gejala, individu dengan ILTB berpotensi mengembangkan TBC aktif di masa mendatang, terutama jika sistem kekebalan tubuh melemah.

Orang dengan ILTB apabila dilakukan Tuberculin Skin Test (TST) atau pemeriksaan Interferon Gamma-Release Assay (IGRA) hasilnya akan positif, tetapi hasil pemeriksaan rontgen thorax normal serta hasil pemeriksaan dahak dan Xpert MTB/Rif® negative. WHO (2023) memperkirakan sekitar 1,7 miliar orang hidup dengan ILTB secara global. Di Indonesia, menurut Kemenkes RI (2022), prevalensi ILTB mencapai 35–45% populasi dewasa, terutama pada kelompok risiko tinggi seperti petugas kesehatan, orang dengan HIV, dan kontak serumah dengan pasien TBC aktif.

B. Faktor Risiko ILTB & Kelompok Rentan

1. Paparan terhadap Mikobakterium Tuberculosis
ILTB terjadi saat seseorang menghirup droplet nuklei dari penderita TB aktif yang mengandung MTb. Setelah masuk ke paru, bakteri akan dihadapi oleh sistem imun.
2. Respon Imun Inang
Ketika MTb menginfeksi alveoli, makrofag akan menangkap bakteri ini. Dalam kebanyakan kasus, sistem imun seluler membentuk granuloma (struktur pertahanan) untuk menahan infeksi. Jika granuloma terbentuk sempurna, bakteri akan tetap "terkurung" dalam keadaan dorman, menciptakan ILTB.
3. Faktor Risiko Lingkungan dan Sosial
 - a. Kontak erat dengan penderita TB aktif

- b. Kondisi sosial ekonomi rendah, termasuk nutrisi buruk, kepadatan hunian, dan akses layanan kesehatan yang rendah
 - c. Kondisi geografis, misalnya tinggal di daerah endemis TB
4. Komorbiditas dan Imunosupresi
- a. Individu dengan HIV/AIDS memiliki risiko tinggi ILTB berkembang menjadi TB aktif (WHO, 2023)
 - b. Diabetes mellitus, gagal ginjal kronik, dan penggunaan obat imunosupresif (seperti TNF- α inhibitors) juga meningkatkan risiko

C. Fenomena ILTB di Dunia & Indonesia

Secara global, TBC tetap menjadi salah satu penyakit menular paling mematikan. Pada tahun 2023, TBC kembali menjadi penyebab utama kematian akibat penyakit menular, dengan 1,25 juta kematian yang dilaporkan. Negara-negara seperti India, Indonesia, China, Filipina, dan Pakistan menyumbang 56% dari total kasus TBC dunia. Berdasarkan data WHO, sekitar seperempat populasi global diperkirakan telah terinfeksi bakteri TB. Meskipun sebagian besar individu tidak akan mengembangkan penyakit TB aktif, mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah, seperti pengidap HIV, malnutrisi, atau diabetes, memiliki risiko lebih tinggi untuk jatuh sakit.

Menurut laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam beban TBC, dengan estimasi 824 ribu

kasus baru dan 93 ribu kematian pada tahun 2020. Namun, cakupan pemberian TPT untuk mencegah perkembangan ILTB menjadi TBC aktif masih rendah, yaitu 5% pada Orang dengan HIV (ODHIV) dan 0,2% pada kontak serumah.

Beberapa studi menunjukkan, 5-10% orang dengan ILTB akan berkembang menjadi TBC aktif, biasanya terjadi dalam 5 tahun sejak pertama kali terinfeksi. Pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, terutama Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), malnutrisi, orang yang sedang menjalani pengobatan kanker atau sedang menjalani dialisis berisiko mengalami penyakit TBC lebih tinggi daripada orang dengan sistem kekebalan tubuh normal. Risiko penyakit TBC pada ODHA, anak kontak serumah dengan pasien TBC terkonfirmasi bakteriologis dan kelompok berisiko lainnya dapat dikurangi dengan pemberian TPT.

Penelitian Kaswandani. N, et al (2022) menekankan pentingnya diagnosis dini dan pemberian TPT pada anak-anak yang berisiko tinggi, seperti mereka yang memiliki kontak erat dengan penderita TBC aktif atau dengan kondisi imunokompromais. Beberapa rekomendasi terapi pencegahan yang disebutkan meliputi pemberian isoniazid selama 6 bulan, kombinasi isoniazid dan rifampisin selama 3 bulan, atau rifampisin selama 4 bulan. Selain itu, pedoman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 juga menekankan pentingnya pemberian TPT

untuk mencegah perkembangan ILTB menjadi TBC aktif, terutama pada kelompok berisiko tinggi. Namun, tantangan dalam implementasi TPT antara lain adalah keraguan petugas kesehatan dalam memberikan terapi ini dan rendahnya cakupan pemberian TPT pada populasi berisiko.

ILTB yang berkembang menjadi penyakit TBC diantara 1.7 milyar penduduk yang terinfeksi TBC akan bertambah setiap tahun. Review sistematis yang dilakukan terhadap 11 penelitian di Asia Tenggara menunjukkan 24,4% sampai 69,2% anak umur di bawah 15 tahun berkontak dengan orang TBC aktif dan 3,3% sampai 5,5% di antaranya akan berkembang menjadi TBC aktif.

D.Terapi Pencegahan TBC (TPT) Sebagai Bagian dari Pelayanan Tuberkulosis

Pemberian TPT kepada individu dengan ILTB, terutama mereka yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif, merupakan langkah penting dalam mencegah perkembangan TB aktif. Selain itu, deteksi dini dan pengobatan yang tepat bagi penderita TB aktif dapat mengurangi penularan dan, pada akhirnya, menurunkan prevalensi ILTB di masyarakat. Hal ini sejalan dengan target eliminasi TB pada tahun 2030, dimana salah satu strateginya adalah "Optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, termasuk pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT)" (Kemenkes RI, 2023).

TPT merupakan strategi penting dalam upaya eliminasi TB, terutama bagi individu yang memiliki risiko tinggi berkembang menjadi TB aktif. TPT diberikan kepada individu dengan infeksi TB laten, yaitu mereka yang telah terpapar bakteri *MTb* tetapi belum menunjukkan gejala klinis penyakit TB aktif. Tujuan utama TPT adalah untuk membunuh bakteri yang masih dalam fase dorman sehingga dapat mencegah perkembangan menjadi TB aktif. Kelompok yang menjadi sasaran utama pemberian TPT meliputi:

1. Kontak erat pasien TB aktif; terutama anak-anak dan individu dengan gangguan imunitas,
2. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA); yang memiliki risiko tinggi mengalami TB aktif.
3. Pasien dengan kondisi immunosupresif, seperti penderita diabetes melitus atau pasien yang menjalani terapi immunosupresif, dan
4. Individu dengan hasil tes tuberkulin atau interferon-gamma release assay (IGRA) positif.

Regimen TPT yang digunakan bervariasi tergantung pada kondisi pasien dan ketersediaan obat. Beberapa regimen yang direkomendasikan antara lain:

1. **Isoniazid (INH) selama 6-9 bulan:** Ini adalah regimen standar yang telah lama digunakan dalam pencegahan TB.
2. **Rifampisin selama 4 bulan:** Alternatif bagi individu yang tidak toleran terhadap isoniazid.

3. Kombinasi Isoniazid dan Rifapentin selama 3 bulan:

Regimen dengan kepatuhan lebih baik karena durasi lebih singkat.

Obat-obatan ini bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri *MTb*, sehingga mencegah reaktivasi bakteri yang masih dalam keadaan dorman.

E. Algoritma Pemberian TPT (Mengacu pada WHO & Kemenkes RI)

TBC masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat global, terutama di negara-negara dengan beban tinggi seperti Indonesia. Salah satu strategi krusial dalam mengendalikan penyebaran TBC adalah TPT, yang ditujukan untuk mencegah perkembangan TB aktif pada individu dengan risiko tinggi. Namun, implementasi TPT memerlukan langkah sistematis mulai dari identifikasi sasaran hingga evaluasi keberhasilan terapi.

Berikut adalah Langkah – langkah pelaksanaan TPT berbasis pedoman WHO & Kemenkes RI.

Langkah 1: Identifikasi Sasaran TPT Kelompok risiko tinggi:

- a. Kontak serumah dengan pasien TB aktif, terutama anak <5 tahun.
- b. Orang dengan HIV (ODHIV).
- c. Pasien yang menerima imunosupresan (misalnya: terapi biologik, kemoterapi).
- d. Penderita diabetes melitus, gagal ginjal kronis, malnutrisi berat.

Langkah 2: Skrining TB Aktif

Skrining dilakukan untuk memastikan bahwa individu tidak menderita TB aktif, karena TPT tidak diberikan jika sudah sakit TB. Metode skrining TB aktif:

- a. Anamnesis gejala: batuk >2 minggu, demam, berat badan turun, berkeringat malam.
- b. Pemeriksaan fisik dan penunjang:
 - Tes Mantoux atau IGRA (jika tersedia).
 - Rontgen toraks.
 - Pemeriksaan dahak jika ada gejala.

Jika hasil skrining menunjukkan TB aktif: → Rujuk untuk pengobatan TB aktif, bukan TPT.

Langkah 3: Evaluasi Kontra Indikasi dan Kesiediaan Pasien, Pastikan:

- a. Tidak ada riwayat hipersensitivitas terhadap obat TPT (misalnya INH).
- b. Tidak ada penyakit hati aktif (karena hepatotoksitas).
- c. Edukasi dan informed consent diberikan.

Langkah 4: Pilih Regimen TPT

Regimen TPT	Frek	Durasi	Obat
6H	Harian	6 bulan	Isoniazid harian
3RH	Harian	3 bulan	Rifampisin + Isoniazid
3HP	1 x per minggu	3 bulan	Rifapentin + Isoniazid (1x/minggu)
1HP	Harian	1 bulan	Rifapentin + Isoniazid (harian, hanya untuk ODHIV)

- WHO (2020) merekomendasikan **3RH** atau **3HP** karena **kepatuhan lebih baik** dan efek samping lebih sedikit.
- Di Indonesia, **6H** dan **3RH** paling banyak digunakan karena ketersediaan obat.

Langkah 5: Monitoring dan Evaluasi

- a. Pemantauan efek samping setiap bulan: hepatotoksitas, neuropati.
- b. Berikan vitamin B6 (piridoksin) untuk mencegah neuropati perifer, terutama pada ODHIV.
- c. Edukasi kepatuhan sangat penting.
- d. Dokumentasi dan pelaporan ke program TB nasional.

F. Tantangan dan Peluang dalam Memperluas Jangkauan TPT

TPT merupakan bagian integral dari pelayanan TB, merupakan salah satu strategi penting dalam pengendalian TBC yang bertujuan untuk mencegah perkembangan infeksi laten menjadi penyakit aktif. Meskipun implementasinya menghadapi berbagai tantangan, strategi yang tepat dalam edukasi, pemantauan, dan penguatan sistem kesehatan dapat meningkatkan efektivitas program ini. Implementasi TPT memiliki tantangan besar yang berkaitan dengan aspek klinis, operasional, kebijakan, serta sosial dan budaya. Di sisi lain, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas cakupan TPT guna menurunkan insidensi TBC. Dengan kerja sama antara

tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan TB melalui TPT dapat semakin optimal dalam mendukung eliminasi.

Dalam praktiknya, implementasi TPT menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan deteksi dini infeksi TB laten, kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat, serta keterbatasan sumber daya dalam sistem kesehatan. Program TPT harus melibatkan pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya terapi ini.

Beberapa tantangan utama dalam penerapan TPT antara lain:

1. Tantangan Klinis dan Farmakologis

- a. Efektivitas dan Resistensi Obat

Kekhawatiran terhadap resistensi obat, terutama terhadap Isoniazid dan Rifapentin, yang digunakan dalam TPT, serta kepatuhan pasien yang rendah dapat meningkatkan risiko resistensi, terutama di daerah dengan angka resistensi TBC yang tinggi.

- b. Efek Samping Obat

Beberapa pasien mengalami hepatotoksisitas, reaksi alergi, atau efek samping lain yang menghambat kepatuhan dalam menjalani terapi, dan monitoring efek samping memerlukan sistem pengawasan yang kuat dan sumber daya kesehatan yang cukup.

- c. Deteksi dan Diagnosis Infeksi Laten

- Tidak semua fasilitas kesehatan memiliki akses ke tes diagnosis infeksi laten seperti IGRA (Interferon-Gamma Release Assay) atau TST (Tuberculin Skin Test).
 - Akurasi deteksi kasus laten masih menjadi tantangan, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya laboratorium.
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Banyak Masyarakat tidak menyadari bahwa mereka memiliki infeksi laten dan tidak memahami pentingnya terapi pencegahan. Miskonsepsi ini menghambat penerimaan TPT, terutama karena pasien merasa tidak sakit.
 3. Kepatuhan Pasien Rendah

Durasi terapi yang cukup panjang (3-6 bulan) menyebabkan beberapa pasien mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pengobatan.
 4. Keterbatasan Sumber Daya

Tidak semua fasilitas kesehatan memiliki kapasitas untuk melakukan deteksi dini dan pemantauan pasien TPT secara optimal (Ketersediaan obat TPT, tenaga kesehatan terlatih, serta sistem pencatatan dan pelaporan masih menjadi kendala, terutama di daerah terpencil).
 5. Stigma terhadap TBC

Adanya stigma terhadap TBC membuat banyak orang enggan terlibat dalam skrining atau pengobatan preventif. Hal ini menghambat tracing dan pengobatan kontak.

Sementara beberapa peluang dalam memperluas jangkauan TPT adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Global dan Nasional

Strategi nasional eliminasi TBC 2030 dan dukungan WHO serta Global Fund menciptakan kerangka kebijakan yang kuat untuk implementasi TPT.

2. Inovasi dalam Formulasi Obat

Tersedianya regimen jangka pendek seperti 3HP (isoniazid dan rifapentine selama 3 bulan) menawarkan alternatif dengan kepatuhan lebih baik dan efek samping minimal.

3. Penguatan Sistem Informasi dan Digitalisasi

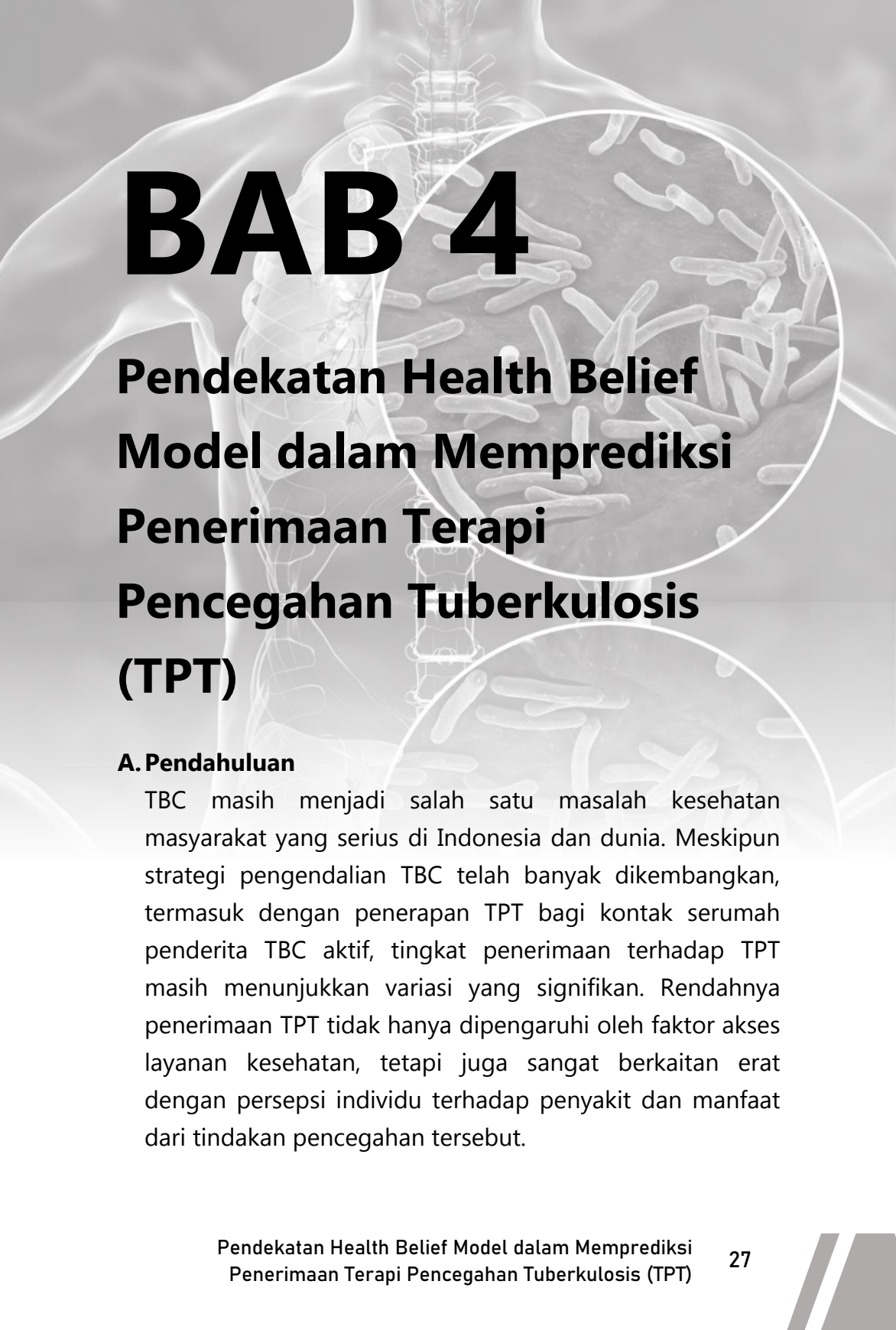
Pemanfaatan teknologi untuk pelaporan, pemantauan, dan edukasi pasien mendukung perluasan layanan TPT secara efisien.

4. Keterlibatan Komunitas dan LSM

Kader kesehatan dan organisasi masyarakat memiliki peran strategis dalam edukasi, deteksi dini, dan pendampingan pasien TPT.

5. Integrasi dengan Layanan Primer

Pelaksanaan TPT di layanan primer (puskesmas) memungkinkan deteksi dini dan pengobatan yang lebih terintegrasi dalam pelayanan kesehatan rutin.



BAB 4

Pendekatan Health Belief Model dalam Memprediksi Penerimaan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT)

A. Pendahuluan

TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia dan dunia. Meskipun strategi pengendalian TBC telah banyak dikembangkan, termasuk dengan penerapan TPT bagi kontak serumah penderita TBC aktif, tingkat penerimaan terhadap TPT masih menunjukkan variasi yang signifikan. Rendahnya penerimaan TPT tidak hanya dipengaruhi oleh faktor akses layanan kesehatan, tetapi juga sangat berkaitan erat dengan persepsi individu terhadap penyakit dan manfaat dari tindakan pencegahan tersebut.

Dalam konteks ini, pendekatan psikologi kesehatan seperti Health Belief Model (HBM) menjadi sangat relevan untuk menjelaskan perilaku kesehatan masyarakat, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan individu untuk menerima atau menolak TPT. HBM adalah suatu kerangka teori yang telah banyak digunakan dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku preventif terhadap berbagai penyakit menular maupun tidak menular. Model ini menekankan bahwa keyakinan personal seseorang terhadap kerentanan terhadap penyakit, tingkat keparahan penyakit, manfaat dari tindakan pencegahan, hambatan yang dirasakan, serta adanya isyarat untuk bertindak (cue to action), menjadi determinan utama dalam membentuk keputusan untuk bertindak secara preventif.

Penerapan HBM dalam konteks penerimaan TPT memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mengidentifikasi faktor-faktor psikososial yang dapat diintervensi melalui edukasi, konseling, dan kebijakan berbasis bukti. Pemahaman yang mendalam mengenai setiap komponen utama dari HBM tidak hanya memberikan penjelasan tentang rendahnya penerimaan TPT di masyarakat, tetapi juga membuka peluang untuk merancang strategi komunikasi kesehatan yang lebih efektif dan berorientasi pada perubahan perilaku.

Bagian ini akan membahas secara rinci enam komponen utama dari HBM, yaitu; *perceived susceptibility*, *perceived severity*, *perceived benefits*, *perceived barriers*, *cues to action*, dan *self-efficacy*, serta bagaimana masing-masing komponen tersebut berkontribusi terhadap keputusan individu atau keluarga dalam menerima TPT. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan celah intervensi yang relevan untuk meningkatkan cakupan penerimaan TPT sebagai bagian dari upaya eliminasi TBC di Indonesia.

B. *Perceived Susceptibility* dalam Memprediksi Penerimaan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT)

Perceived susceptibility atau kerentanan yang dirasakan adalah persepsi individu mengenai kemungkinan atau risiko dirinya terinfeksi atau terkena suatu penyakit (Rosenstock, 1974). Konsep ini merupakan salah satu komponen utama dalam Health Belief Model (HBM), yang digunakan untuk memahami perilaku kesehatan, termasuk kepatuhan terhadap terapi atau pencegahan penyakit menular seperti tuberkulosis.

Dalam konteks TBC, *perceived susceptibility* mengacu pada keyakinan seseorang bahwa dirinya berisiko tinggi terinfeksi TBC aktif, terutama bila ia adalah kontak serumah dari pasien TBC. Tingkat kerentanan yang dirasakan ini sangat penting untuk memengaruhi keputusan seseorang untuk menerima atau menolak TPT; TPT merupakan intervensi yang ditujukan bagi individu

dengan infeksi TB laten (LTBI) atau yang berisiko tinggi (misalnya anak, lansia, penderita HIV, atau kontak serumah) agar tidak berkembang menjadi TBC aktif.

Semakin tinggi seseorang meyakini bahwa dirinya berisiko tertular atau sakit TBC aktif, maka semakin besar kemungkinan ia menerima TPT. Persepsi ini dapat dipengaruhi oleh: 1) Pengetahuan tentang TBC dan risiko penularan, 2) Riwayat paparan terhadap penderita TBC dalam rumah, 3) Pengalaman pribadi atau keluarga dengan TBC, 4) Kampanye edukasi kesehatan yang efektif, dan 5) tatus kekebalan tubuh (misalnya penderita HIV lebih merasa rentan). Sebaliknya, persepsi rendah terhadap risiko dapat menyebabkan penolakan TPT karena individu merasa sehat, tidak mengalami gejala, atau menganggap TPT tidak perlu.

Sebuah penelitian di Delhi, India, menginformasikan bahwa 73.5% kontak serumah bersedia menerima TPT, meskipun sebagian besar belum pernah mendengar tentang infeksi TBC laten. Fakta ini menunjukkan bahwa persepsi risiko memengaruhi niat untuk menerima TPT (Sharma N, et al (2022). Penelitian oleh Parwati et al. (2021) menunjukkan bahwa pendekatan HBM melalui wawancara motivasional mampu meningkatkan kepatuhan dan keberhasilan pengobatan TBC. Hal ini tidak terlepas dari penguatan persepsi individu terhadap keparahan TBC sebagai pendorong motivasi perubahan perilaku. Sementara Azizi et al. (2018) menemukan bahwa perceived

threat, salah satu factor yang mempengaruhi kepatuhan pengobatan TBC di Iran.

Temuan lain di Afrika Selatan menginformasikan bahwa hambatan dalam implementasi program TPT meliputi kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan, desain intervensi, dan sumber daya. Namun, sikap positif tenaga kesehatan dan kemitraan yang ada dapat menjadi fasilitator untuk keberhasilan program (Van de Water, et al. 2023). Hal ini berbanding terbalik dengan fakta di India, bahwa tenaga kesehatan memiliki pengetahuan dan sikap yang lebih baik terkait pencegahan TBC dibandingkan pasien, pengetahuan yang baik dikaitkan dengan persepsi risiko yang lebih tinggi terhadap TBC (Shihora et al, 2024).

Studi tentang faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa di Shandong, China, menolak TPT setelah awalnya bersedia. Persepsi kerentanan terhadap TBC ditemukan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keputusan tersebut (Yuan. Y, et al, 2023). Pengetahuan tentang TBC meningkatkan persepsi individu terhadap *susceptibility* dan *severity*, yang secara langsung mendorong mereka untuk mengambil tindakan pencegahan. Studi Internasional melibatkan 278 keluarga kontak serumah, mengevaluasi kesiediaan kontak rumah tangga untuk menjalani TPT terhadap TBC resisten obat. Ditemukan bahwa persepsi risiko tinggi terhadap TBC meningkatkan kesiediaan individu untuk menerima TPT, pengetahuan

yang tepat terkait TB (OR, 2,22 [95% CI, 1,23-3,99]) meningkatkan kesediaan mereka untuk menerima TPT (Suryavanshi. N, et al, 2020).

Studi kualitatif yang dilakukan di Selangor, Malaysia, melalui 26 wawancara mendalam; menginformasikan bahwa pengetahuan yang baik tentang tuberkulosis (TB) aktif dan komplikasi yang terkait, termasuk keseriusan dan penularan TB aktif, memudahkan pengobatan (Manoharan. A, et al, 2023). Oleh karena itu tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan yang komprehensif berperan dalam memfasilitasi TPT. Sementara penelitian yang dilakukan di Uganda melibatkan 104 pasien HIV, menunjukkan bahwa memberikan pilihan kepada pasien dalam pengambilan keputusan terkait TPT meningkatkan efikasi diri dan niat mereka untuk menyelesaikan terapi. Persepsi individu terhadap kerentanan mereka terhadap TBC berperan dalam motivasi mereka untuk memulai dan menyelesaikan terapi pencegahan (Rachel.K.Lim. et al, 2021), (Kaaffah S, et la, 2023), (Ismail A, et al, 2014).

Sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara komponen-komponen Model Keyakinan Kesehatan, dengan menggunakan convenience sampling, 1154 pekerja migran dari desa ke kota yang berusia antara 18-50 tahun di enam wilayah perkotaan di tiga provinsi di Cina dipilih, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan dan tingkat keparahan memprediksi pencarian layanan TB ($\beta = 0,12, 0,16$). Selanjutnya, masing-masing

kerentanan ($\beta = 0,30$) dan keparahan ($\beta = 0,41$) memprediksi manfaat yang dirasakan dari perawatan pencegahan (Li. Z.T, et al, 2015).

Secara psikologis, ketika individu memahami bahwa TBC bukan hanya penyakit yang menular, tetapi juga dapat menyebabkan komplikasi paru, kecacatan, bahkan kematian, maka muncul kesadaran akan perlunya perlindungan. Penerimaan terhadap TPT menjadi bentuk konkrit dari respons perlindungan ini. Hal ini juga berkaitan dengan rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat, karena TBC merupakan penyakit infeksius yang berdampak luas. Dengan kata lain, *perceived severity* menciptakan tekanan internal yang memotivasi individu untuk bertindak. Jika seseorang tidak melihat TBC sebagai masalah serius, maka mereka cenderung menolak atau mengabaikan tawaran TPT. Beberapa faktor yang memengaruhi keyakinan individu terhadap kerentanan TBC meliputi: pengetahuan; Individu dengan pemahaman yang baik tentang penularan TBC lebih mungkin merasa rentan (Suryavanshi. N, et al, 2020), pengalaman pribadi; seseorang yang pernah menyaksikan dampak TBC dalam keluarga cenderung memiliki persepsi risiko yang lebih tinggi, sumber informasi; edukasi dari tenaga kesehatan dan media yang kredibel mampu membentuk persepsi yang lebih realistis, dan nilai budaya dan stigma; dalam beberapa komunitas TBC masih dianggap memalukan sehingga dapat menurunkan kesediaan untuk menerima diagnosis atau pencegahan.

Keyakinan tentang kerentanan terhadap TBC memiliki hubungan yang signifikan dengan penerimaan TPT. Persepsi yang rendah terhadap risiko infeksi TBC dapat menjadi penghambat utama dalam implementasi program pencegahan. Oleh karena itu, strategi penguatan persepsi kerentanan yang berbasis pada edukasi dan komunikasi yang tepat sasaran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keberhasilan program TPT, terutama di negara dengan beban TBC tinggi seperti Indonesia, seperti; pendidikan kesehatan yang kontekstual: memberikan informasi yang sesuai dengan tingkat literasi masyarakat lokal. Penyuluhan berbasis komunitas: melibatkan tokoh masyarakat atau kader untuk menyampaikan risiko TBC. Pendekatan komunikasi interpersonal: tenaga kesehatan perlu melibatkan pasien secara emosional dan rasional dalam proses edukasi. Dan pemanfaatan media digital: menyebarkan konten visual dan testimoni dari penyintas dapat meningkatkan persepsi kerentanan dan urgensi pencegahan.

C. *Perceived Severity* dalam Memprediksi Penerimaan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT)

Perceived severity adalah salah satu komponen utama dari Health Belief Model (HBM) yang mengacu pada keyakinan individu tentang tingkat keparahan atau dampak serius dari suatu penyakit apabila tidak dilakukan tindakan pencegahan atau pengobatan. Dalam konteks TPT, persepsi keparahan merujuk pada sejauh mana keluarga atau individu percaya bahwa TBC adalah penyakit yang

berat, menular, dan dapat menimbulkan komplikasi serius hingga kematian jika tidak dicegah.

Menurut Rosenstock (1974), *perceived severity* mencakup dua aspek: keparahan klinis (misalnya kematian, kesakitan, kecacatan) dan keparahan sosial (misalnya stigma, isolasi sosial, hilangnya pekerjaan). TPT merupakan terapi pencegahan yang diberikan kepada individu yang memiliki kontak erat dengan penderita TBC aktif namun belum menunjukkan gejala (*latent TB infection*), terutama pada kelompok berisiko seperti anak-anak dan lansia.

Ketika seseorang memiliki persepsi bahwa TBC adalah penyakit serius dengan konsekuensi yang berat, mereka lebih cenderung: 1) Menerima TPT sebagai upaya perlindungan terhadap infeksi laten yang bisa berkembang menjadi TBC aktif., 2) Melibatkan diri secara aktif dalam pengobatan dan pemantauan Kesehatan, dan 3) Mengabaikan hambatan ringan (seperti efek samping ringan) demi menghindari risiko besar (misalnya menderita TBC).

Berbagai penelitian internasional mendukung temuan ini. Sebuah penelitian potong lintang di Delhi, India, terhadap 536 kontak rumah tangga menunjukkan bahwa walaupun 97,3% partisipan tidak pernah mendengar tentang infeksi TB laten, 73,5% bersedia menerima TPT. Alasan utama keengganan termasuk tidak adanya gejala (33,1%), merasa sangat sehat (42,9%), dan kekhawatiran tentang efek

samping obat (27,5%) (Sharma et al., 2022). Sebuah penelitian di Cina yang melibatkan 7.017 responden dari populasi umum menunjukkan bahwa tingkat kesadaran yang tinggi tentang bahaya TB meningkatkan penerimaan TPT. Namun, stigma sosial diketahui dapat melemahkan hubungan antara pengetahuan tentang TB dan kemauan untuk menerima TPT (Ciotti et al., 2020). Sebuah penelitian kualitatif di enam klinik juga mengungkapkan bahwa tingkat keparahan TB yang dirasakan dan keyakinan akan manfaat TPT merupakan faktor penentu yang penting dalam keputusan pasien untuk menjalani pengobatan (Manoharan et al., 2023).

Sebuah tinjauan sistematis terhadap intervensi profesional dan faktor penentu kepatuhan terhadap pengobatan tuberkulosis paru berdasarkan HBM menunjukkan bahwa persepsi keparahan dan manfaat pengobatan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pasien (Martono et al., 2023). Penelitian lain di India yang menggunakan model HBM mengidentifikasi sembilan alasan utama ketidakpatuhan, termasuk pengaruh konseling negatif dari dukun yang melemahkan persepsi tingkat keparahan, serta perbaikan gejala yang menurunkan persepsi manfaat pengobatan (Solanki et al., 2022).

Penelitian di Jawa Barat, Indonesia, yang melibatkan 524 mahasiswa berusia ≥ 18 tahun, menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap terhadap skrining, pengobatan,

dan edukasi pencegahan TBC mempengaruhi perilaku pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang sadar akan bahaya TB lebih mungkin untuk melakukan tindakan pencegahan (Puspitasari et al., 2022). Sebuah penelitian di Provinsi Shandong, Cina, terhadap 723 mahasiswa dengan infeksi TB laten menunjukkan bahwa meskipun pada awalnya mereka menerima TPT, 60,3% kemudian menolak. Namun, mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang TB lebih kecil kemungkinannya untuk menolak (OR = 0,97; 95% CI: 0,95-0,99). Hal ini mencerminkan bahwa persepsi yang kuat tentang bahaya TB dapat memperkuat komitmen untuk melakukan pencegahan (Yuan et al., 2023).

Sebuah studi terhadap 1.154 pekerja migran di tiga provinsi di Cina menunjukkan bahwa persepsi kerentanan dan keparahan TB memprediksi perilaku pencegahan dan pencarian layanan TB ($\beta = 0,12$ dan $0,16$), variabel ancaman yang dirasakan, termasuk tingkat keparahan, manfaat, hambatan, dan efikasi diri, menyumbang 42% dari variasi dalam kepatuhan terapeutik, efikasi diri merupakan prediktor terkuat untuk perilaku pencegahan dan pencarian layanan TB ($\beta = 0,12$ dan $0,16$, masing-masing) (Li et al., 2015). Persepsi yang tinggi tentang keparahan TB secara signifikan berhubungan dengan penerimaan yang tinggi terhadap TPT. Individu yang menyadari bahwa TB adalah penyakit yang serius cenderung lebih proaktif dalam mengikuti terapi pencegahan daripada mereka yang menganggap TB tidak

berbahaya. Prediktor terkuat dari kepatuhan adalah efikasi diri. Individu yang memiliki keyakinan yang kuat tentang bahaya dan dampak serius dari TB cenderung lebih waspada dan merasa terdorong untuk melakukan tindakan pencegahan seperti TPT. Hal ini karena keyakinan tentang tingkat keparahan penyakit dapat menciptakan rasa urgensi dan motivasi untuk menghindari konsekuensi yang merugikan.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam instrumen penelitian mencerminkan tingkat pemahaman responden mengenai potensi kematian, penularan, komplikasi, penurunan kualitas hidup, dan dampak pengobatan. Ketika individu menyadari bahwa TB bukan hanya penyakit biasa, tetapi penyakit yang dapat menyebabkan kematian dan mengganggu produktivitas, maka individu akan lebih mudah menerima upaya pencegahan seperti TPT. Nilai OR sebesar 7,796 menunjukkan bahwa keyakinan positif tentang tingkat keparahan TB sangat mempengaruhi penerimaan TPT. Artinya, persepsi yang kuat tentang keseriusan TB mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam program pencegahan. Persepsi ini meliputi bahaya TB terhadap kehidupan atau produktivitas, potensi komplikasi atau kematian, stigma dan diskriminasi sosial, dan dampak terhadap keluarga atau ekonomi. Individu yang percaya bahwa TB adalah penyakit yang berbahaya cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk melakukan tindakan pencegahan, termasuk menerima TPT.

Dengan demikian, temuan ini memperkuat literatur yang ada bahwa persepsi keparahan penyakit TB memainkan peran penting dalam mempromosikan penerimaan TPT. Intervensi promotif dan edukatif harus berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang dampak serius dari TB sebagai strategi untuk meningkatkan keberhasilan program eliminasi TB di masyarakat. Edukasi harus mencakup konsekuensi medis dan sosial dari TB, efektivitas dan keamanan TPT, pengurangan stigma terkait TB, dan petugas kesehatan harus mengintegrasikan pendekatan komunikasi yang memperkuat persepsi yang realistis tentang keparahan TB, dengan penekanan pada manfaat TPT sebagai tindakan pencegahan yang penting.

D. *Perceived Benefits* (Manfaat yang Dirasakan)

Perceived benefits adalah sejauh mana seseorang meyakini bahwa suatu tindakan atau perilaku akan memberikan manfaat bagi kesehatannya. Dalam konteks perawatan kesehatan, ini merujuk pada pandangan seseorang terhadap keuntungan yang bisa diperoleh dari melakukan suatu perubahan perilaku atau menjalani pengobatan tertentu. Individu yang memahami bahwa TPT dapat secara signifikan mengurangi risiko progresi dari infeksi laten menjadi TBC aktif, lebih cenderung untuk menjalani terapi.

Tingkat penerimaan TPT di masyarakat masih relatif rendah, padahal efektivitas program ini dalam mencegah perkembangan infeksi laten menjadi penyakit TB aktif

telah terbukti secara ilmiah. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi penerimaan adalah keyakinan individu terhadap manfaat TPT itu sendiri. Mengacu pada teori Health Belief Model (HBM), perilaku kesehatan sangat dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap kerentanan terhadap penyakit, tingkat keparahan, manfaat tindakan pencegahan, dan hambatan yang dirasakan. Keyakinan terhadap manfaat TPT mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa berpartisipasi dalam program ini akan memberikan manfaat bagi kesehatan, seperti mencegah TB aktif, melindungi keluarga dari penularan, dan memperpanjang usia harapan hidup. Dalam konteks kontak serumah, keyakinan ini merupakan komponen kunci dalam membentuk motivasi untuk menerima dan menjalani program TPT.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, manfaat yang dirasakan telah terbukti menjadi faktor penentu utama dalam perilaku kesehatan, terutama dalam pencegahan penyakit menular seperti TB. Dalam kerangka kerja HBM, manfaat yang dirasakan merupakan faktor motivasi yang kuat karena individu lebih mungkin untuk mengikuti suatu intervensi jika mereka percaya bahwa intervensi tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi kesehatan mereka (Rosenstock, 1974). Studi tentang implementasi pengobatan pencegahan TB di daerah dengan prevalensi tinggi menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan dari TPT yang kuat memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan individu. Selain itu, studi ini menekankan

pentingnya menempatkan pasien sebagai pusat dari kebijakan perluasan TPT, dan menegaskan bahwa sistem kesehatan perlu memastikan program ini dapat dilaksanakan dengan aman, efisien, dan berkelanjutan untuk meningkatkan motivasi dan kepatuhan pasien dalam menjalani terapi (Fox et al., 2021).

Penelitian kualitatif di masyarakat pedesaan Afrika Selatan mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat tentang efek samping pengobatan TB merupakan penghalang utama terhadap kepatuhan. Hambatan lain termasuk kurangnya pemahaman petugas kesehatan tentang manfaat TPT, tidak adanya alur dokumentasi yang jelas, dan sumber daya yang terbatas di masyarakat. Namun, minat petugas kesehatan untuk belajar dan menyelesaikan hambatan logistik merupakan faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi program (Watermeyer & Penn, 2019). Hambatan dan fasilitator dalam investigasi kontak TB dan manajemen TPT di daerah pedesaan Eastern Cape, Afrika Selatan, hasil analisis data menunjukkan bahwa hambatan umum yang teridentifikasi adalah kurangnya pengetahuan penyedia layanan tentang manfaat TPT, kurangnya alur kerja dokumentasi TPT untuk dokter, dan keterbatasan sumber daya masyarakat yang meluas. Faktor pendukung yang diidentifikasi termasuk minat petugas kesehatan yang tinggi untuk belajar lebih banyak tentang efektivitas TPT, dan minat untuk mengatasi hambatan logistik dalam penyediaan layanan TB yang komprehensif (termasuk TPT) (van de Water et al., 2023).

Sebuah penelitian di Cina yang melibatkan 7.017 responden menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pengobatan untuk infeksi TB laten (TBI) mencapai 84,38%, dengan korelasi positif yang signifikan antara tingkat pengetahuan tentang TB dan penerimaan TBI (OR = 1,096; 95% CI: 1,073-1,118). Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman yang baik tentang TB dan manfaat pengobatannya akan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap TPT (Ciotti et al., 2020). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa memiliki tingkat kesadaran yang tinggi tentang TB termasuk manfaat pengobatan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pengobatan TB.

Studi di Australia, tentang vaksinasi influenza dengan menggunakan pendekatan teori HBM menemukan bahwa prediktor terkuat dari perilaku vaksinasi adalah keyakinan bahwa vaksin tersebut efektif dalam mencegah penyakit (APR = 3,71; 95% CI: 2,87-4,80), yang sekali lagi menekankan peran utama dari manfaat yang dirasakan dalam pengambilan keputusan kesehatan (Trent et al., 2021). Penelitian lain di Delhi menunjukkan bahwa sekitar 73,5% kontak serumah pasien TB bersedia menerima TPT, tetapi persepsi “merasa sehat” dan kekhawatiran tentang efek samping merupakan hambatan utama. Studi ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran tentang manfaat TPT, bahkan pada individu yang tidak mengalami gejala (Sharma et al., 2022).

Sebuah penelitian di Jepara, Jawa Tengah, Indonesia mengidentifikasi kurangnya pengetahuan tentang TB dan TPT sebagai penyebab utama ketidakpatuhan. Banyak orang merasa bahwa mereka tidak memerlukan pengobatan karena merasa sehat. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan yang efektif perlu menekankan manfaat nyata dari TPT, termasuk kemampuannya untuk mengurangi risiko infeksi TB aktif hingga 60-90% (WHO, 2023).

Komunikasi interpersonal berbasis empati telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri pasien dalam menjalani terapi. Tenaga kesehatan juga memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan sumber informasi yang dipercaya masyarakat. Berdasarkan hasil uji statistik ($p < 0,05$ dan $OR = 7,197$), keyakinan positif terhadap manfaat TPT terbukti memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penerimaan program. Keyakinan ini berperan sebagai dasar motivasi yang memperkuat keputusan individu untuk menerima TPT, sejalan dengan teori HBM. Ketika seseorang percaya bahwa TPT dapat mencegah penularan TB ke keluarga, menjaga kesehatan, memberikan perlindungan jangka panjang, dan memiliki manfaat yang lebih besar daripada risikonya, maka program ini akan dilihat sebagai investasi kesehatan, bukan sebagai beban.

Keyakinan akan manfaat TPT juga memperkuat rasa tanggung jawab kolektif untuk kesehatan keluarga dan

mendorong tindakan proaktif. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat bukti global bahwa persepsi manfaat merupakan salah satu faktor kunci dalam penerimaan program TPT. Temuan ini menjadi dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan dan petugas kesehatan untuk merancang strategi promosi kesehatan berbasis edukasi yang berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang manfaat TPT sebagai bagian integral dari upaya eliminasi TB.

E. *Perceived Barriers* (Hambatan yang Dirasakan)

Perceived Barriers adalah persepsi individu terhadap hambatan atau kesulitan yang mungkin mereka hadapi dalam mengambil tindakan kesehatan yang disarankan. Hambatan ini bisa berupa berbagai faktor, baik eksternal (seperti keterbatasan ekonomi atau akses ke layanan kesehatan) maupun internal (seperti ketakutan, kebiasaan, atau persepsi pribadi terhadap efektivitas pengobatan). Dalam konteks pengelolaan penyakit, hambatan yang dirasakan oleh pasien sering kali memengaruhi keputusan mereka untuk mengikuti pengobatan atau menjaga perubahan gaya hidup yang dianjurkan. Persepsi akan hambatan ini dapat secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap pengobatan, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil kesehatan pasien.

Menurut model ini, meskipun seseorang menyadari bahwa mereka rentan terhadap suatu penyakit dan menganggap penyakit tersebut serius, serta memahami manfaat dari

tindakan pencegahan atau pengobatan, mereka mungkin tidak bertindak jika mereka merasakan banyak hambatan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Hambatan yang dirasakan bisa sangat bervariasi antar individu, tergantung pada konteks sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis. Beberapa jenis hambatan yang sering ditemukan dalam pengelolaan Kesehatan diantaranya adalah

1. Hambatan Ekonomi:

- a. Biaya Pengobatan: Banyak individu menganggap biaya pengobatan atau perawatan medis sebagai hambatan utama dalam pengambilan keputusan kesehatan. Biaya yang tinggi untuk obat-obatan, pemeriksaan medis, atau rawat inap dapat membuat seseorang ragu untuk memulai atau melanjutkan pengobatan.
- b. Akses ke Layanan Kesehatan: Keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan atau kurangnya ketersediaan perawatan kesehatan yang terjangkau di daerah tertentu juga dapat menjadi hambatan besar.

2. Hambatan Sosial dan Budaya:

- a. Norma Sosial: Beberapa individu mungkin merasa dipengaruhi oleh norma sosial yang ada di lingkungan mereka. Misalnya, ada stigma terkait dengan penyakit tertentu, yang membuat individu enggan untuk mencari bantuan medis atau mengikuti pengobatan.
- b. Perbedaan Budaya dan Keyakinan: Dalam beberapa budaya, ada pandangan bahwa pengobatan tradisional lebih efektif daripada pengobatan medis

modern, atau ada ketakutan terhadap efek samping obat-obatan. Pandangan ini bisa menjadi hambatan dalam mengambil tindakan medis yang disarankan.

3. Hambatan Psikologis:

- a. Rasa Takut atau Kecemasan: Ketakutan terhadap diagnosis medis atau rasa cemas terhadap prosedur medis (seperti suntikan atau efek samping obat) bisa menjadi hambatan yang signifikan. Misalnya, pasien dengan hipertensi mungkin khawatir tentang efek samping obat pengatur tekanan darah, yang bisa membuat mereka enggan memulai pengobatan.
- b. Kecemasan tentang Efektivitas: Beberapa individu mungkin meragukan efektivitas dari perawatan atau pengobatan tertentu, merasa bahwa hasilnya tidak akan memadai atau bahwa mereka tidak dapat memperoleh manfaat yang diinginkan.

4. Hambatan Fisik:

- a. Keterbatasan Mobilitas: Orang yang memiliki keterbatasan fisik atau penyakit yang membatasi kemampuan mereka untuk bergerak mungkin merasa sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan atau mengikuti instruksi medis yang memerlukan kegiatan fisik tertentu (seperti olahraga atau terapi fisik).
- b. Kelelahan atau Ketidaknyamanan: Beberapa pasien merasa lelah atau tidak nyaman mengikuti rejimen pengobatan yang ketat, terutama jika pengobatan tersebut mempengaruhi rutinitas sehari-hari mereka.

5. Hambatan Waktu:

Kesibukan Sehari-hari: Banyak individu merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu untuk pergi ke dokter, mengikuti pengobatan, atau membuat perubahan gaya hidup yang dianjurkan. Ini bisa menjadi hambatan besar, terutama di kalangan orang-orang yang memiliki pekerjaan sibuk atau banyak tanggung jawab keluarga.

Meskipun manfaat TPT telah banyak dibuktikan melalui studi klinis, namun tingkat penerimaan di berbagai kalangan masih relatif rendah. Salah satu faktor penentu utama yang mempengaruhi rendahnya penerimaan adalah persepsi tentang hambatan dalam menjalani TPT, seperti kekhawatiran akan efek samping, durasi pengobatan yang lama, dan ketidakpercayaan akan efektivitas TPT. Health Belief Model (HBM) merupakan kerangka teori yang umum digunakan untuk memahami perilaku kesehatan, termasuk dalam konteks penerimaan intervensi pencegahan seperti TPT. Salah satu konstruk utama dari HBM adalah hambatan yang dirasakan, yang didefinisikan sebagai pandangan individu terhadap berbagai hambatan atau konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari tindakan kesehatan tertentu (Glanz & Bishop, 2010; Rosenstock, 1974).

Menurut teori HBM, semakin tinggi persepsi seseorang terhadap hambatan, semakin kecil kemungkinan orang tersebut untuk mengambil tindakan pencegahan, termasuk TPT. Penelitian cross-sectional sebelumnya telah

menemukan bahwa kekhawatiran akan efek samping obat merupakan salah satu hambatan utama untuk memulai dan menyelesaikan pengobatan infeksi TB laten (Kane et al., 2013). Di Malaysia, sebuah penelitian yang melibatkan enam klinik menunjukkan bahwa kurangnya informasi dari petugas kesehatan dan kekhawatiran akan efek samping merupakan hambatan dalam pelaksanaan terapi (Manoharan et al., 2023).

Demikian pula, sebuah penelitian multisenter di Cina melaporkan bahwa 57,8% responden meragukan keefektifan TPT dan 32,7% mengkhawatirkan efek samping obat tersebut. Ketakutan akan efek samping, durasi pengobatan yang lama, hambatan keuangan, dan kurangnya transportasi ke klinik merupakan hambatan utama untuk memulai dan menyelesaikan pengobatan infeksi TB laten. Penelitian kualitatif di beberapa provinsi di Indonesia dengan prevalensi TB yang tinggi juga mengidentifikasi lima hambatan utama dari sudut pandang pasien, yaitu kurangnya pengetahuan tentang TB, stigma, jarak ke fasilitas kesehatan, efek samping obat, dan hilangnya pendapatan rumah tangga (Pradipta et al., 2021). Tinjauan literatur lain bahkan menyebutkan bahwa hambatan ekonomi, budaya, sosial, dan sistem kesehatan dapat menjadi penghambat kepatuhan pengobatan dan skrining TB (Tomás et al., 2013).

Terdapat lima pernyataan yang dikembangkan untuk mengukur persepsi individu terhadap hambatan dalam melakukan TPT menunjukkan gambaran yang konsisten tentang berbagai faktor penghambat. Pertama, pada pernyataan "Saya merasa kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan yang menyediakan TPT", sebagian besar responden memberikan nilai yang tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan aksesibilitas layanan, baik dari segi jarak, biaya transportasi, waktu, maupun ketersediaan layanan TPT di fasilitas kesehatan setempat. Faktor ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa jarak merupakan hambatan utama dalam mengakses layanan kesehatan. Kedua, kekhawatiran terhadap efek samping TPT juga menjadi pertimbangan besar, tercermin dari tingginya skor pada pernyataan "Saya khawatir akan mengalami efek samping jika menggunakan TPT". Hal ini menunjukkan bahwa persepsi risiko terhadap pengobatan masih mendominasi.

Menurut penelitian tersebut, persepsi yang berlebihan terhadap potensi efek samping dapat menurunkan motivasi pasien untuk memulai atau melanjutkan terapi, meskipun risikonya rendah dan dapat dikelola. Dalam sebuah penelitian di Malaysia yang melibatkan enam klinik, hasilnya menginformasikan bahwa kurangnya penjelasan yang memadai dari petugas kesehatan serta kekhawatiran tentang efek samping obat merupakan hambatan utama dalam penerapan TPT (Manoharan et al., 2023).

Ketiga, durasi pengobatan yang panjang juga merupakan hambatan yang penting. Pada pernyataan “Jadwal pengobatan TPT terlalu lama dan membuat saya ragu untuk mengikutinya,” responden cenderung setuju. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen jangka panjang terhadap terapi, yang biasanya berlangsung selama 3 hingga 6 bulan, dianggap sebagai beban (Rizqiya, 2021). Durasi pengobatan yang panjang sering kali menyebabkan ketidakpatuhan atau penolakan terhadap TPT, terutama pada individu yang tidak bergejala. Keempat, faktor sosial seperti stigma juga muncul sebagai alasan yang signifikan. Pernyataan “Saya merasa malu jika orang lain tahu bahwa saya menggunakan TPT” menggambarkan ketakutan akan pandangan negatif dari masyarakat atau lingkungan sekitar. Stigma terhadap TB dan TPT masih menjadi masalah umum di banyak masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh (Suratmini, Dwi, 2024), di mana rasa malu atau takut dianggap dapat mengurangi pencapaian program penanggulangan TB.

Kelima, tantangan terkait kedisiplinan dalam menjalani terapi jangka panjang turut berkontribusi terhadap rendahnya penerimaan TPT. Tanggapan terhadap pernyataan “Saya ragu bisa disiplin mengikuti TPT setiap hari selama beberapa bulan” menegaskan bahwa efikasi diri atau kepercayaan diri untuk menyelesaikan terapi masih rendah. Dalam sebuah penelitian oleh (Rahmadi et al.) Secara keseluruhan, hambatan psikologis, sosial, dan logistik merupakan faktor utama rendahnya penerimaan

TPT. Berdasarkan kerangka kerja HBM, hambatan yang dirasakan merupakan prediktor yang kuat terhadap perilaku kesehatan.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan TPT perlu dilakukan melalui edukasi yang komprehensif, terutama mengenai manfaat, efek samping, dan pentingnya menyelesaikan terapi. Pendekatan berbasis komunitas untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Memperkuat sistem dukungan dan pemantauan, seperti kunjungan rumah, pengingat digital, atau layanan TPT yang lebih fleksibel dan terjangkau. Intervensi yang komprehensif dan berbasis kebutuhan lokal diperlukan untuk meningkatkan partisipasi kontak rumah tangga dalam program TPT.

F. *Cues to Action* (Isyarat untuk Bertindak)

Cues to Action atau Isyarat untuk Bertindak, dalam HBM, *Cues to Action* diartikan sebagai rangsangan eksternal maupun internal yang memicu individu untuk mengambil tindakan dalam mengubah atau mempertahankan perilaku kesehatan. Dalam kerangka HBM, salah satu komponen penting yang mempengaruhi perilaku pencegahan adalah isyarat untuk bertindak (Anggraini, 2024), (Yulianti et al., 2022).

Menurut HBM, meskipun seseorang memiliki persepsi bahwa dirinya rentan (*perceived susceptibility*), bahwa kondisi tersebut serius (*perceived severity*), bahwa

tindakan memiliki manfaat (perceived benefits), dan hambatan dapat diatasi (perceived barriers), mereka belum tentu melakukan perubahan perilaku tanpa adanya pemicu atau isyarat. Cues to Action dapat bersifat internal maupun eksternal:

1. Internal cues:

Suatu isyarat yang bersumber dalam diri seseorang, misal; Gejala fisik seperti nyeri dada, sesak napas, pusing, atau tanda-tanda penyakit lain. Dan Perasaan khawatir, takut, atau cemas tentang kesehatan sendiri.

2. External cues:

Isyarat yang bersumber dari luar diri seseorang, misalnya; Kampanye kesehatan publik (iklan layanan masyarakat, poster, media sosial), nasihat atau dorongan dari tenaga kesehatan (dokter, perawat, konselor), pengalaman orang terdekat (misalnya keluarga atau teman yang sakit atau meninggal karena penyakit tertentu), reminder atau notifikasi digital dari aplikasi Kesehatan, dan edukasi kesehatan di sekolah, tempat kerja, atau komunitas.

Berbagai bentuk isyarat telah terbukti efektif dalam memperkuat motivasi individu untuk menerima TPT, salah satunya adalah pendidikan kesehatan, yang telah terbukti menjadi pemicu penting untuk intervensi. Pendidikan kesehatan yang terstruktur dan berbasis masyarakat di wilayah puskesmas dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan pencegahan TBC (Puspitawati, 2019). Dorongan atau saran dari petugas kesehatan secara

langsung mempengaruhi keputusan pasien untuk memulai TPT. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi interpersonal antara petugas kesehatan (dokter, perawat) dan pasien sangat penting, karena dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan mengurangi ketakutan akan efek samping serta kesalahpahaman tentang pengobatan (Nabila, 2023).

Sebuah survei tentang penggunaan TPT di antara kontak rumah tangga pasien TB di Distrik Murshidabad, Bengal Barat, mengungkapkan bahwa alasan utama responden tidak melakukan TPT adalah karena TPT tidak ditawarkan oleh petugas kesehatan. Hal ini menegaskan bahwa petugas kesehatan berperan sebagai isyarat penting yang dapat memotivasi individu untuk bertindak (Mukherjee et al., 2024). Selain itu, intervensi kesehatan berbasis teknologi, seperti aplikasi seluler, juga dapat menjadi bentuk isyarat yang efektif untuk mendorong penerimaan TPT (Lee et al., 2023).

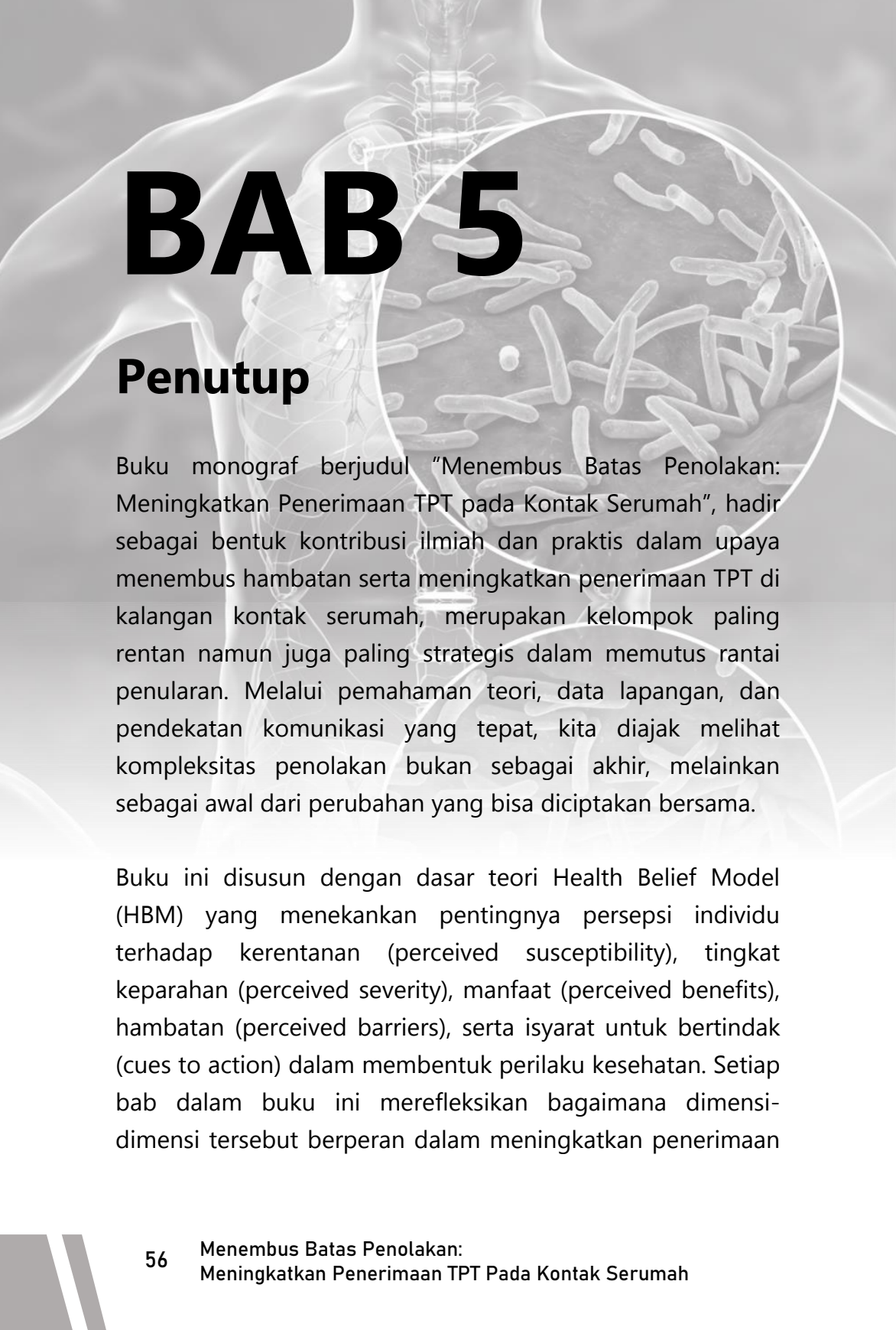
Sebuah tinjauan sistematis lain menunjukkan bahwa dukungan keluarga, baik secara emosional maupun praktis (misalnya pengawasan asupan obat dan dorongan untuk hidup sehat), dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi pasien untuk menyelesaikan pengobatan (Lutfian et al., 2025). Pasien yang mendapat pengawasan dari anggota keluarga, dukungan spiritual, dan memiliki hubungan yang baik dengan petugas kesehatan serta pemahaman yang baik tentang TB, cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap

pengobatan. Selain itu, tokoh masyarakat dan agama (seperti kiai atau tokoh adat) juga dapat menjadi isyarat yang efektif dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program TPT, karena mereka memiliki pengaruh yang besar di masyarakat (Chen et al., 2020). Secara konseptual, isyarat untuk bertindak tidak hanya sebagai pemicu pasif, tetapi juga berfungsi sebagai penguat sikap dan keyakinan terhadap manfaat TPT. Hal ini sejalan dengan hasil analisis kuesioner penelitian, di mana sebagian besar responden menyatakan bahwa penyuluhan dari petugas kesehatan membantu mereka memahami pentingnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang edukatif dan komunikatif oleh tenaga kesehatan merupakan pemicu yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan sikap positif masyarakat.

Selain itu, informasi dari media massa dan media sosial juga berperan penting. Media berperan dalam menjangkau khalayak luas dan menyampaikan pesan-pesan kesehatan yang dapat menarik perhatian masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi tentang TB dan memperkuat persepsi masyarakat tentang risiko dan manfaat pengobatan. Sementara itu, dukungan dari keluarga merupakan isyarat internal yang memperkuat niat dan komitmen seseorang untuk memulai dan menyelesaikan pengobatan TPT. Dalam konteks budaya kolektif seperti di Indonesia, keputusan yang berkaitan dengan kesehatan sering kali melibatkan pertimbangan

dan dukungan keluarga. Motivasi individu juga meningkat ketika mereka melihat keberhasilan orang lain dalam menjalani TPT. Pengalaman tersebut menjadi proses pembelajaran sosial yang memperkuat keyakinan akan efektivitas tindakan tersebut. Terakhir, rekomendasi langsung dari dokter atau perawat terbukti meningkatkan kepercayaan diri dan kemauan individu untuk menerima TPT. Interaksi langsung yang disertai dengan penjelasan yang meyakinkan dari tenaga kesehatan berperan dalam membangun persepsi positif terhadap program.

Isyarat untuk bertindak bukan hanya pemicu pasif, tetapi juga berfungsi sebagai penguat sikap dan keyakinan akan manfaat TPT. Penerapan strategi komunikasi yang tepat melalui berbagai bentuk isyarat dapat menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan, sehingga dapat mempercepat pencapaian target eliminasi TBC. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan antara lain mengintegrasikan pendidikan dan konseling sebagai bagian dari program rutin, melibatkan petugas kesehatan, keluarga, dan tokoh masyarakat dalam kampanye TPT, menggunakan media sosial dan teknologi digital untuk menyebarkan pesan TPT secara luas dan berulang-ulang, serta merancang testimoni dan narasi positif dari penyintas TB laten sebagai alat komunikasi yang membumi dan efektif.



BAB 5

Penutup

Buku monograf berjudul “Menembus Batas Penolakan: Meningkatkan Penerimaan TPT pada Kontak Serumah”, hadir sebagai bentuk kontribusi ilmiah dan praktis dalam upaya menembus hambatan serta meningkatkan penerimaan TPT di kalangan kontak serumah, merupakan kelompok paling rentan namun juga paling strategis dalam memutus rantai penularan. Melalui pemahaman teori, data lapangan, dan pendekatan komunikasi yang tepat, kita diajak melihat kompleksitas penolakan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari perubahan yang bisa diciptakan bersama.

Buku ini disusun dengan dasar teori Health Belief Model (HBM) yang menekankan pentingnya persepsi individu terhadap kerentanan (perceived susceptibility), tingkat keparahan (perceived severity), manfaat (perceived benefits), hambatan (perceived barriers), serta isyarat untuk bertindak (cues to action) dalam membentuk perilaku kesehatan. Setiap bab dalam buku ini merefleksikan bagaimana dimensi-dimensi tersebut berperan dalam meningkatkan penerimaan

TPT, disertai dengan bukti-bukti ilmiah, pengalaman praktik lapangan, serta strategi inovatif berbasis komunitas.

Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus praktis kepada tenaga kesehatan, peneliti, mahasiswa, dan pembuat kebijakan, tentang bagaimana pendekatan berbasis teori perilaku dapat diimplementasikan dalam konteks nyata untuk mengurangi penolakan TPT. Melalui pemaparan yang sistematis dan berbasis data, penulis berharap buku ini dapat menjadi rujukan sekaligus inspirasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengendalian tuberkulosis, terutama di wilayah dengan beban kasus tinggi.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam pengendalian TBC tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan intervensi medis, tetapi juga oleh kekuatan edukasi, komunikasi, dan kepekaan terhadap nilai-nilai budaya serta keyakinan masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengajak para pembaca untuk tidak sekadar membaca buku ini, tetapi juga merenungkan dan menerapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dalam praktik sehari-hari.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, terutama kepada para narasumber, rekan sejawat, tim penelitian, dan institusi yang telah memberikan dukungan moral, material, dan intelektual. Semoga segala upaya ini menjadi bagian dari kontribusi kolektif kita dalam

menciptakan masyarakat yang lebih sehat, sadar, dan terbebas dari belenggu tuberkulosis.

Akhir kata, semoga buku ini membawa manfaat dan menjadi pijakan awal bagi perubahan perilaku yang lebih baik dalam menerima dan melaksanakan TPT sebagai langkah preventif yang bermakna. Karena sejatinya, menembus batas penolakan bukan hanya soal mengubah pikiran, tetapi juga membangun harapan dan komitmen untuk kehidupan yang lebih sehat dan bermartabat.

Daftar Pustaka

- Anggraini, V. (2024). HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG TERAPI PENCEGAHAN TUBERKULOSIS (TPT) DENGAN PEMBERIAN TERAPI PENCEGAHAN TUBERKULOSIS (TPT) PADA KELUARGA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KEDONDONG TAHUN 2024. *Repository UMPRI*.
- Azizi, N., Karimy, M., & Salahshour, V. N. (2018). Determinants of adherence to tuberculosis treatment in Iranian patients: Application of health belief model. *Journal of Infection in Developing Countries*, 12(9). <https://doi.org/10.3855/jidc.9653>
- Chen, X., Du, L., Wu, R., Xu, J., Ji, H., Zhang, Y., Zhu, X., & Zhou, L. (2020). The effects of family, society and national policy support on treatment adherence among newly diagnosed tuberculosis patients: A cross-sectional study. *BMC Infectious Diseases*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12879-020-05354-3>
- Christopher Dye, Philippe Glaziou, Katherine Floyd, and M. R. (2013). Prospects for Tuberculosis Elimination. *Annual Review of Public Health*, 34.
- Ciotti, M., Ciccozzi, M., Terrinoni, A., Jiang, W. C., Wang, C. Bin, & Bernardini, S. (2020). The COVID-19 pandemic. *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, 57(6), 365–388. <https://doi.org/10.1080/10408363.2020.1783198>
- Fox, G. J., Nguyen, T. A., Coleman, M., Trajman, A., Velen, K., & Marais, B. J. (2021). Implementing tuberculosis preventive treatment in high-prevalence settings. *International Journal of Infectious Diseases*, 113. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.02.094>
- Glanz, K., & Bishop, D. B. (2010). The role of behavioral science theory in development and implementation of public health interventions. In *Annual Review of Public Health* (Vol. 31). <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.012809.103604>

- Ismail, A., & Josephat, P. (2014). Knowledge and perception on tuberculosis transmission in Tanzania: Multinomial logistic regression analysis of secondary data. *Tanzania Journal of Health Research*, 16(1). <https://doi.org/10.4314/thrb.v16i1.5>
- Kaaffah, S., Kusuma, I. Y., Renaldi, F. S., Pratiwi, A. D. E., Bahar, M. A., & Lestari, Y. E. (2023). Knowledge, Attitudes, and Perceptions of Tuberculosis in Indonesia: A Multi-Center Cross-Sectional Study. *Infection and Drug Resistance*, 16. <https://doi.org/10.2147/IDR.S404171>
- Kane, M., Korn, B., Saukkonen, J., McDonald, C., Walsh, C., Waters, R., McLaughlin, A. M., & Keane, J. (2013). Barriers to accepting and completing latent tuberculosis infection treatment. *Irish Medical Journal*, 106(7), 200–204.
- Kemenkes RI. (2016). Info Datin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI Tuberkulosis (Temukan Obat Sampai Sembuh). In *Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI* (pp. 2–10).
- Kemenkes RI. (2018). Tuberkulosis (TB). *Tuberkulosis*, 1(april), 2018. www.kemendes.go.id
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis 2021. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lee, S., Rajaguru, V., Baek, J. S., Shin, J., & Park, Y. (2023). Digital Health Interventions to Enhance Tuberculosis Treatment Adherence: Scoping Review. In *JMIR mHealth and uHealth* (Vol. 11, Issue 1). <https://doi.org/10.2196/49741>
- Li, Z. T., Yang, S. S., Zhang, X. X., Fisher, E. B., Tian, B. C., & Sun, X. Y. (2015). *Complex relation among Health Belief Model components in TB prevention and care*. 9. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2015.04.008>
- Lutfian, L., Azizah, A., Wardika, I. J., Wildana, F., Maulana, S., & Wartakusumah, R. (2025). The role of family support in medication adherence and quality of life among tuberculosis

- patients: A scoping review. *Japan Journal of Nursing Science : JJNS*, 22(1), e12629. <https://doi.org/10.1111/jjns.12629>
- Manoharan, A., Siti Nur Farhana, H., Manimaran, K., Khoo, E. M., & Koh, W. M. (2023). Facilitators and barriers for tuberculosis preventive treatment among patients with latent tuberculosis infection: a qualitative study. *BMC Infectious Diseases*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12879-023-08612-2>
- Martono, M., Akhyar, M., Pamungkasari, E. P., & Lestari, A. (2023). Results of professional interventions to improve medication adherence based on health beliefs and important determinants of tuberculosis medication: a systematic review. In *European Review for Medical and Pharmacological Sciences* (Vol. 27, Issue 24). https://doi.org/10.26355/eurrev_202312_34778
- Mukherjee, O., Das, D. K., Adhikary, M., & Ghosh, R. (2024). IJCM_285A: Tuberculosis Preventive Treatment among the Household Contacts of Tuberculosis Patients – Coverage and Correlates in a Block of Murshidabad District, West Bengal: A Cross-sectional Study. In *Indian Journal of Community Medicine: Official Publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine* (Vol. 49, Issue Suppl 1, p. S83). https://doi.org/10.4103/ijcm.ijcm_abstract285
- Murray, P. R., Rosenthal, K. S., & Pfaller, M. A. (2022). *Medical Microbiology* (10th ed.). Philadelphia: Elsevier.
- Nabila, N. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Minum Obat Anti Tuberkulosis (OAT) pada Penderita Tuberkulosis Paru (TB): Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(8). <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i8.3484>
- Parwati, N. M., Bakta, I. M., Januraga, P. P., & Wirawan, I. M. A. (2021). A health belief model-based motivational interviewing for medication adherence and treatment success in pulmonary tuberculosis patients. *International*

- Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(24).
<https://doi.org/10.3390/ijerph182413238>
- Pradipta, I. S., Idrus, L. R., Probandari, A., Lestari, B. W., Diantini, A., Alffenaar, J. W. C., & Hak, E. (2021). Barriers and strategies to successful tuberculosis treatment in a high-burden tuberculosis setting: a qualitative study from the patient's perspective. *BMC Public Health*, 21(1).
<https://doi.org/10.1186/s12889-021-12005-y>
- Puspitasari, I. M., Sinuraya, R. K., Aminudin, A. N., & Kamilah, R. R. (2022). Knowledge, Attitudes, and Preventative Behavior Toward Tuberculosis in University Students in Indonesia. *Infection and Drug Resistance*, 15.
<https://doi.org/10.2147/IDR.S365852>
- Puspitawati, T. (2019). Rancang Bangun Sistem Pengajuan Ethical Clearance pada Komisi Etik Penelitian Universitas Respati Yogyakarta, Daerah Istimewa Yoogyakarta. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 35(4), OP14-3.
<https://jurnal.ugm.ac.id/bkm/article/view/44340>
- Rahmadi, M. A., Nasution, H., Mawar, L., Dewi, I. S., Nasution, R., & Sari, M. (2024). *Hubungan Motivasi terhadap Keberhasilan Pengobatan Endometriosis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , Indonesia Universitas Negeri Padang , Indonesia Universitas Sumatera Utara , Indonesia Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah , Indo.* 2(4).
- Rizqiya, R. N. (2021). Hubungan Stigma Masyarakat Dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Tb Paru Di Puskesmas Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 17(1), 66–76.
- Rosenstock, I. M. (1974). Historical Origins of the Health Belief Model. *Health Education & Behavior*, 2(4).
<https://doi.org/10.1177/109019817400200403>
- Sharma, N., Basu, S., Khanna, A., Sharma, P., & Chandra, S. (2022). The intention to receive tuberculosis preventive therapy in

- adult household contacts of pulmonary TB patients in Delhi, India. *Journal of Infection in Developing Countries*, 16(2). <https://doi.org/10.3855/jidc.14910>
- Shihora, J., Damor, N. C., Parmar, A., Pankaj, N., & Murugan, Y. (2024). *Knowledge , Attitudes , and Preventive Practices Regarding Tuberculosis Among Healthcare Workers and Patients in India: A Mixed-Method Study*. 16(3). <https://doi.org/10.7759/cureus.56368>
- Solanki, N., Sharma, P., Rupani, M. P., & Goswami, B. (2022). "I lost my faith and stopped taking the medicines" – need for an intervention model based on health belief constructs for improving adherence to tuberculosis treatment. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 11(6). https://doi.org/10.4103/jfmmpc.jfmmpc_2128_21
- Sulistiyono, R. E., Sukartini, T., Makhfudli, M., Nursalam, N., Rr Soenarnatalina M, R. S. M., & Hidayati, L. (2018). PENINGKATAN EFIKASI DIRI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TUBERKULOSIS BERBASIS BUDAYA. *Journal of Health Sciences*, 10(2). <https://doi.org/10.33086/jhs.v10i2.130>
- Suratmini, Dwi, and L. B. T. (2024). Hubungan stigma dan efikasi diri dengan kepatuhan pengobatan obat anti tuberkulosis (OAT) pasien tuberkulosis: Literatur review. *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, 2(4), 225–253.
- Suryavanshi, N., Murrill, M., Gupta, A., Hughes, M., Hesseling, A., Kim, S., Naini, L., Jones, L., Smith, B., Gupte, N., Dawson, R., Mave, V., Meshram, S., Mendoza-Ticona, A., Sanchez, J., Kumarasamy, N., Comins, K., Conradie, F., Shenje, J., ... Shah, N. S. (2020). Willingness to take multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) preventive therapy among adult and adolescent household contacts of MDR-TB index cases: An international multisite cross-sectional study. *Clinical Infectious Diseases*, 70(3). <https://doi.org/10.1093/cid/ciz254>
- TB/HIV Symposium 2019: "A new era in TB prevention: Implications for people living with HIV". (2019). *The Aurum Institute*.

- Tomás, B. A., Pell, C., Cavanillas, A. B., Solvas, J. G., Pool, R., & Roura, M. (2013). Tuberculosis in migrant populations. A systematic review of the qualitative literature. In *PLoS ONE* (Vol. 8, Issue 12). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0082440>
- Trent, M. J., Salmon, D. A., & MacIntyre, C. R. (2021). Using the health belief model to identify barriers to seasonal influenza vaccination among Australian adults in 2019. *Influenza and Other Respiratory Viruses*, 15(5). <https://doi.org/10.1111/irv.12843>
- van de Water, B. J., Wilson, M., le Roux, K., Gaunt, B., Gimbel, S., & Ware, N. C. (2023). Healthcare worker perceived barriers and facilitators to implementing a tuberculosis preventive therapy program in rural South Africa: a content analysis using the consolidated framework for implementation research. *Implementation Science Communications*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/s43058-023-00490-8>
- Watermeyer, J., & Penn, C. (2019). Community perspectives on tuberculosis care in rural South Africa. *Health and Social Care in the Community*, 27(1). <https://doi.org/10.1111/hsc.12637>
- World Health Organization 2023. (2023). Report 20-23. In *January: Vol. Global TBC* (Issue March).
- World Health Organization. (2023). Global Tuberculosis Report 2023. Geneva: WHO.
- Yuan, Y., Jin, J., Bi, X., Geng, H., Li, S., & Zhou, C. (2023). Factors associated with refusal of preventive therapy after initial willingness to accept treatment among college students with latent tuberculosis infection in Shandong, China. *BMC Infectious Diseases*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12879-023-08005-5>
- Yulianti, E., Agusthia, M., & Noer, R. M. (2022). *Hubungan Self-Efficacy dan Cues to Action dengan Perilaku Loss to Follow Up pada Pasien HIV / AIDS dengan Terapi ARV*. 58(November).

Glosarium



BTA	: Basil Tahan Asam
Cues to Action	: Rangsangan eksternal maupun internal yang memicu individu untuk mengambil tindakan dalam mengubah atau mempertahankan perilaku kesehatan.
DOTS	: Directly Observed Treatment Shortcourse
HBM	: Health Belief Model
HIV/AIDS	: Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome
ILTB	: Infeksi Laten Tuberkulosis
IGRA	: Interferon-Gamma Release Assays
MDR	: Multi-Drug-Resistant
MTb	: Mycobacterium tuberculosis
OAT	: Obat Anti Tuberkulosis
ODHA	: Orang Dengan HIV/AIDS
PMO	: Pengawas Menelan Obat
Perceived Susceptibility	: Persepsi individu mengenai kemungkinan atau risiko dirinya terinfeksi atau terkena suatu penyakit
Perceived Severity	: Keyakinan individu tentang tingkat keparahan atau dampak serius dari suatu penyakit apabila tidak dilakukan tindakan pencegahan atau pengobatan
Perceived benefits	: Sejauh mana seseorang meyakini bahwa suatu tindakan

	atau perilaku akan memberikan manfaat bagi kesehatannya
Perceived Barriers	: Persepsi individu terhadap hambatan atau kesulitan yang mungkin mereka hadapi dalam mengambil tindakan kesehatan yang disarankan
TBC	: Tuberkulosis
TPT	: Terapi Pencegahan Tuberkulosis
TST	: Tuberculin Skin Test
WHO	: World Health Organization

Profil Penulis



Nur Fadhillah, M.Kes, Ph.D. lahir di Gisting Kabupaten Tanggamus, 20 Juli 1975 dari seorang ayah bernama Khozin Abdullah dan ibu Fairah Marhamah. Menikah dengan M.Yusup dan dikarunia 2 orang putra (M. Haeqal Phasa & M. Zidane Al-Ghifarry) dan seorang putri (Keysha Yasmine Asshafira). Pendidikan terakhir S3 diselesaikan di Mahsa

Universty Malaysia tahun 2023. Kariernya dimulai pada tahun 1998 sebagai perawat pelaksana di RSUAM Propinsi Lampung, di tahun yang sama penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Aktif sebagai dosen pengajar pada tahun 2000 sampai dengan sekarang dengan kekhususan Mata Kuliah; Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik, Promosi Kesehatan, dan Metode Penelitian. Sebagai bentuk dedikasi penulis dalam dunia pendidikan, penulis telah menghasilkan berbagai buku dan karya ilmiah, program penanggulangan TBC adalah satu aktivitas social yang dilakukan penulis berkoordinasi dengan dinas terkait. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan PPNI Kabupaten Pringsewu, Kood. Indonesia Ramah Lansia (IRL), sebagai ketua Majelis Kesehatan PDA Kota Bandar Lampung, dan sebagai anggota MPKSDU PWM Lampung

“Don't stop when you're tired, stop when you're done”

Profil Penulis



Iwan Tri Bowo, S.Kom., M.T.I,

Lahir di Pringsewu, 09 Juni 1995 dari seorang ayah bernama Sugeng Santoso dan ibu Tri Lestari Ningsih. Menikah dengan Lili Suryati, A.Md.Kep. dan dikarunia 2 orang putri; Kaina Arsyila Farzana dan Khaira Haura Zahira). Pendidikan terakhir S2 Magister Teknologi Informasi di Institut Informatika dan Bisnis

Darmajaya prodi Teknik Informatika Lampung.

SINOPSIS BUKU

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC aktif. Sayangnya, upaya pencegahan melalui TPT masih menghadapi tantangan besar berupa rendahnya penerimaan oleh kelompok kontak serumah. Buku monograf ini hadir sebagai kontribusi ilmiah dan praktis dalam menjawab permasalahan tersebut.

Menembus Batas Penolakan membedah secara mendalam faktor-faktor penentu penerimaan TPT, mulai dari persepsi kerentanan, keparahan penyakit, manfaat dan hambatan terapi, hingga peran isyarat bertindak dan dukungan tenaga kesehatan. Disusun berdasarkan hasil penelitian berbasis komunitas, buku ini mengintegrasikan pendekatan teori Health Belief Model, data statistik mutakhir, dan temuan empiris yang menggugah kesadaran.

Lebih dari sekadar mengungkap angka dan fakta, monograf ini menawarkan strategi intervensi berbasis komunitas, edukasi kesehatan yang komunikatif, serta rekomendasi kebijakan yang mendorong transformasi sistem layanan TPT. Ditulis dalam bahasa yang lugas namun tetap akademis, buku ini relevan bagi perawat komunitas, tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, hingga peneliti di bidang kesehatan masyarakat.

Menembus batas penolakan bukan hanya tentang mengubah persepsi, tetapi juga tentang membangun komitmen kolektif demi Indonesia bebas TBC.

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC aktif. Sayangnya, upaya pencegahan melalui TPT masih menghadapi tantangan besar berupa rendahnya penerimaan oleh kelompok kontak serumah. Buku monograf ini hadir sebagai kontribusi ilmiah dan praktis dalam menjawab permasalahan tersebut.

Menembus Batas Penolakan membedah secara mendalam faktor-faktor penentu penerimaan TPT, mulai dari persepsi kerentanan, keparahan penyakit, manfaat dan hambatan terapi, hingga peran isyarat bertindak dan dukungan tenaga kesehatan. Disusun berdasarkan hasil penelitian berbasis komunitas, buku ini mengintegrasikan pendekatan teori Health Belief Model, data statistik mutakhir, dan temuan empiris yang menggugah kesadaran.

Lebih dari sekadar mengungkap angka dan fakta, monograf ini menawarkan strategi intervensi berbasis komunitas, edukasi kesehatan yang komunikatif, serta rekomendasi kebijakan yang mendorong transformasi sistem layanan TPT. Ditulis dalam bahasa yang lugas namun tetap akademis, buku ini relevan bagi perawat komunitas, tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, hingga peneliti di bidang kesehatan masyarakat.

Menembus batas penolakan bukan hanya tentang mengubah persepsi, tetapi juga tentang membangun komitmen kolektif demi Indonesia bebas TBC.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



Optimal
Untuk
Negeri



Optimal



IKAPI
INDONESIAN KAP ASSOCIATION

ISBN 978-623-89965-6-8



9

786238

996568